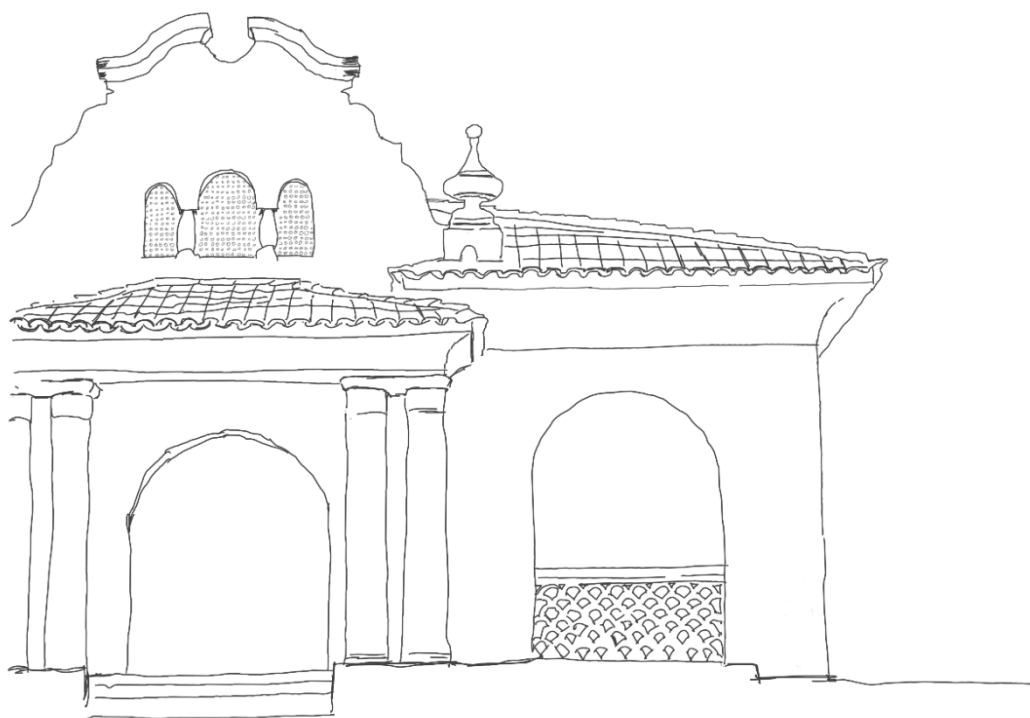


UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

ANA ELISA CAVALCANTE MIRANDA

ARQUITETURA E MEMÓRIA:
Estudo do Antigo Sanatório Meduna em Teresina (PI)



São Paulo

2026

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

ANA ELISA CAVALCANTE MIRANDA

ARQUITETURA E MEMÓRIA:

Estudo do Antigo Sanatório Meduna em Teresina (PI)

São Paulo

2026

ANA ELISA CAVALCANTE MIRANDA

ARQUITETURA E MEMÓRIA:

Estudo do Antigo Sanatório Meduna em Teresina (PI)

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção de título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo.

Orientador: Prof. Dr. Candido Malta Campos Neto

São Paulo

2026

Elaborado com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

M672a Miranda Ana Elisa Cavalcante
Arquitetura e memória : estudo do Antigo Sanatório Meduna em
Teresina (PI) / Ana Elisa Cavalcante Miranda
6,5 MB : il.

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.
Orientador(a) : Drº. Candido Malta Campos Neto

1. Patrimônio. 2. Cidade. 3. Memória. 4. Paisagem Cultural. I.
Campos Neto, Candido Malta, orientador. II. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Paola Alessandra R. D'Amato - CRB 8/6271

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Ana Elisa Cavalcante Miranda

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Arquitetura e Urbanismo

Título do Trabalho: ARQUITETURA E MEMÓRIA: Estudo do Antigo Sanatório Meduna em Teresina (PI)

O presente trabalho foi realizado com o apoio de ¹:

- ☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- ☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- ☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- ☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
- ☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa
- ☐ Empresa/Indústria:
- ☐ Outro:

¹ **Observação:** caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

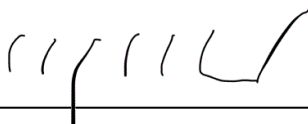
ANA ELISA CAVALCANTE MIRANDA

ARQUITETURA E MEMÓRIA:
Estudo do Antigo Sanatório Meduna em Teresina (PI)

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção de título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo.

Aprovada em:

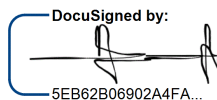
BANCA EXAMINADORA



Prof. Dr. Candido Malta Campos Neto
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. José Geraldo Simões Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie



DocuSigned by:
5EB62B06902A4FA...

Constance De Carvalho Correia Jacob Melo
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Aos meus pais, que sempre acreditaram em mim e tornaram possível cada etapa deste caminho.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é resultado de um percurso iniciado em 2017, com o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso dedicado ao estudo do antigo Sanatório Meduna. Desde então, o interesse pelo tema se manteve e se aprofundou, permitindo que, no mestrado, fosse possível ampliar reflexões, leituras e análises. Concluir esta etapa representa, assim, a continuidade de uma pesquisa construída ao longo dos anos e o amadurecimento de um olhar que se desenvolveu com o tempo.

Agradeço ao meu pai, Elísio, por todo o apoio oferecido ao longo dessa trajetória, mesmo à distância. Seu incentivo constante, a confiança e o cuidado foram fundamentais para que eu seguisse adiante, especialmente nos momentos mais difíceis do processo.

À minha mãe, Ana Paula, agradeço pelas palavras de apoio, pelo acolhimento e pela presença ao longo de todo esse caminho. Seu incentivo diário e sua sensibilidade fizeram muita diferença durante o desenvolvimento da pesquisa.

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Candido Malta Campos Neto, pela orientação cuidadosa, pela disponibilidade e pelas contribuições ao longo do mestrado. Agradeço também aos professores Prof. Dr. José Geraldo Simões Junior e Prof. Dra. Constance de Carvalho Jacob Melo, pelas observações e sugestões realizadas na banca de qualificação, que contribuíram de forma importante para o fortalecimento deste trabalho.

Registro meu agradecimento à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do Programa PROEX, pela bolsa concedida durante o programa de pós-graduação, que possibilitou maior dedicação à pesquisa.

Ao Diego, agradeço pelo apoio constante, pela paciência e pela presença ao longo dessa etapa, especialmente nos momentos finais que exigiram dedicação intensa e compreensão.

Aos meus amigos, agradeço pelo incentivo, pelas conversas, pelas trocas e pela compreensão durante esse período. O apoio, o afeto e a companhia de cada um tornaram esse processo mais leve e possível.

“...Que alegre enchente no meu coração
São dois rios lindos com as águas claras
Desse Parnaíba que não volta mais
Apenas olho minha Teresina
Como quem delira na beira do cais
Ai, troca, quem troca destroca
Minha Teresina não troco jamais
No troca-troca, quem troca destroca
Minha Teresina não troco jamais”

RESUMO

As transformações nas formas de compreender a saúde mental ao longo da história refletiram-se diretamente na materialidade do espaço construído, conformando os chamados lugares da loucura e os espaços da diferença. Este trabalho analisa o antigo Sanatório Meduna, localizado em Teresina (PI), investigando como a arquitetura de instituições voltadas ao cuidado em saúde mental pode ser compreendida como expressão da memória e do patrimônio moderno. Inserida no campo da arquitetura e do urbanismo, a pesquisa contextualiza a implantação do edifício no processo de urbanização da cidade, identifica seus valores históricos, simbólicos e arquitetônicos e analisa as transformações espaciais decorrentes das dinâmicas socioeconômicas e urbanas. Ao discutir as relações entre paisagem, memória e patrimônio, o estudo contribui para a reflexão crítica sobre os sentidos de preservação e esquecimento atribuídos a essas edificações no contexto urbano contemporâneo.

Palavras-chave Patrimônio; Cidade; Memória; Paisagem Cultural

ABSTRACT

The ways in which mental health has been understood throughout history have been directly reflected in the materiality of the built environment, shaping what are commonly referred to as spaces of madness and spaces of difference. This study examines the former Meduna Sanatorium, located in Teresina, Brazil, and investigates how the architecture of institutions dedicated to mental health care can be understood as an expression of memory and modern heritage. Situated within the field of architecture and urbanism, the research contextualizes the building's implementation within the city's urbanization process, identifies its historical, symbolic, and architectural values, and analyzes the spatial transformations resulting from socioeconomic and urban dynamics. By discussing the relationships among landscape, memory, and heritage, the study contributes to a critical reflection on the meanings of preservation and forgetting attributed to these buildings in the contemporary urban context.

Keywords: Heritage; City; Memory; Cultural Landscape

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Planta Baixa do Hospital de Bicêtre.	18
Figura 2 Planta Baixa do Hospital de Salpêtrière.	19
Figura 3 Asilo de Alienados de Sainte-Anne.	21
Figura 4 Asilo de Alienados de Sainte-Anne em 1877.	21
Figura 5 Hospício Pedro II. Litogravura de Pieter Godfred Bertichen, século XIX.	23
Figura 6 Hospício Pedro II. Planta baixa e fachada.	25
Figura 7 Antigo Hospício Pedro II, atual Palácio Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Praia Vermelha.	26
Figura 8 Vista externa do antigo Asilo de Alienados do Juquery.	27
Figura 9 Antiga Estação Juquery, inaugurada em 1888 pela São Paulo Railway, atualmente estação Franco da Rocha.	28
Figura 10 Detalhe do Asilo de Alienados do Juquery, projetado por Ramos de Azevedo em 1898.	29
Figura 11 Mapa do Hospital Central do Juquery.	32
Figura 12 Vista aérea do Complexo Hospitalar do Juquery.	32
Figura 13 Detalhe do Prédio da diretoria após o incêndio de 2005.	33
Figura 14 Casa do Diretor inspirada no Chalet francês.	35
Figura 15 Museu Osório César, 2024.	35
Figura 16 Hospital psiquiátrico Philippe Pinel, em 1929.	36
Figura 17 Área do Hospital psiquiátrico Philippe Pinel.	37
Figura 18 Fachada do Hospital psiquiátrico Philippe Pinel.	38
Figura 19 Hospital psiquiátrico Philippe Pinel, em 1929.	39
Figura 20 Miniatura do Plano de Teresina, esboço do Mestre Isidoro.	42
Figura 21 Avenida Frei Serafim na década de 1940.	43
Figura 22 Mapa da cidade de Teresina com modificações feitas pela autora destacando Avenida Frei Serafim e Avenida Miguel Rosa.	44
Figura 23 Mapas de Teresina nas décadas de 1930 e 1950, respectivamente.	46
Figura 24 Construção da Ponte Juscelino Kubitschek.	47
Figura 25 Mapa de expansão do sistema viário a partir da segunda metade do século XX.	48
Figura 26 Conjunto Habitacional Parque Piauí em 1968.	49
Figura 27 Clidenor de Freitas Santos.	52

Figura 28 Fachada do antigo Sanatório Meduna.	54
Figura 29 Doutor Clidenor de Freitas Santos em sua biblioteca pessoal.	55
Figura 30 Sanatório Meduna na década de 1950.	56
Figura 31 Recorte da notícia do Jornal O DIA.	58
Figura 32 Foto aérea da edificação antes de sua demolição.	60
Figura 33 Foto aérea de parte da edificação depois de sua demolição.	60
Figura 34 Foto aérea de parte da edificação depois de sua demolição.	61
Figura 35 Portas da Igreja São Benedito em Teresina.	63
Figura 36 Monumento aos Heróis do Jenipapo, localizado em Campo Maior.	63
Figura 37 Vista aérea do bairro Porequanto.	65
Figura 38 “Casa cor-de-rosa”, residência construída pelo engenheiro Cícero Ferraz de Souza Martins para sua família.	67
Figura 39 Recorte da notícia do Jornal O DIA com imagem da parte de trás do Sanatório Meduna, em 1954.	67
Figura 40 Representação da planta baixa e fachadas da estrutura existente após a demolição.	68
Figura 41 Sanatório Meduna em 2005, em destaque os blocos que permanecem após a demolição.	69
Figura 42 Fachada do antigo Sanatório Meduna em 2018..	70
Figura 43 Fachada do antigo Sanatório Meduna em 2018.	70
Figura 44 Lateral do Sanatório Meduna e seu acabamento construtivo.	71
Figura 45 Portas do Sanatório Meduna.	71
Figura 46 Detalhe do telhado e forro.	72
Figura 47 Ladrilho do Hall de entrada.	73
Figura 48 Piso do corredor central.	73
Figura 49 Corredores que interligavam os pavilhões (antes da demolição).	74
Figura 50 Parte Externa e Interna da Igreja, em 2018.	74
Figura 51 Fachada da Igreja, após a reforma, em 2021.	75
Figura 52 Interior da Igreja, após a reforma, em 2021.	75
Figura 53 Shopping Rio Poty e Torres Empresariais.	77
Figura 54 Projeto Reserva Rio Poty em 2012.	77
Figura 55 Vista aérea do La Reserve ao lado do Shopping Rio Poty.	78
Figura 56 Vista aérea do La Reserve com parte da estrutura do Sanatório.	79
Figura 57 Cine Rex de Teresina.	82

Figura 58 Vista aérea da Avenida Frei Serafim (ao centro), onde vê-se a predominância de sobrados. Data imprecisa.	82
Figura 59 Vista aérea da Avenida Frei Serafim ocupada por edifícios, em 2023.	83
Figura 60 Rodas de Conversa na Temporada de Carnaval, no prédio do antigo Sanatório Meduna, 2017.	84
Figura 61 Proposta do Museu do Invisível, elaborado em 2018.....	86
Figura 62 Proposta do Museu do Invisível, elaborado em 2018.....	86

LISTA DE ABREVIATURAS

AGESPISA – Agência de Águas e Esgotos do Piauí

BNH – Banco Nacional da Habitação

CEPISA – Companhia Energética do Piauí

COHAB-PI – Companhia de Habitação do Piauí

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo

EDUFPI – Editora da Universidade Federal do Piauí

FRIPISA – Frigorífico do Piauí S.A.

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

PDOT – Plano Diretor de Ordenamento Territorial

SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

SUS – Sistema Único de Saúde

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFPI – Universidade Federal do Piauí

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
Capítulo 1: A Evolução do Espaços de Tratamento Psiquiátrico	16
1.1 Modernidade: Nascimento da psiquiatria e do manicômio psiquiátrico	16
1.2 Os primeiros espaços de manicômio psiquiátrico	18
1.3 Estudo de Caso: Hospício Pedro II (RJ)	22
1.4 Estudo de Caso: Hospital Psiquiátrico do Juqueri (SP)	26
1.5 Estudo de Caso: Hospital psiquiátrico Philippe Pinel (SP)	36
Capítulo 2: O Contexto Histórico de Teresina e o Sanatório Meduna	41
2.1 Desenvolvimento Urbano de Teresina	41
2.1.1 Núcleo Histórico do Rio Parnaíba até o início do século XX	41
2.1.2 Ocupação do Espaço Urbano antes da Ponte JK (1940-1957)	42
2.1.3 Transformações urbanas no entorno do Rio Poti a partir de 1957	46
2.2 O Protagonista: Doutor Clidenor de Freitas Santos	51
2.3 Sanatório Meduna: História e Arquitetura	55
2.3.1 Inauguração e Auge (1954-1990)	55
2.3.3 Declínio e Encerramento (1990-2010)	58
Capítulo 3: Patrimônio e Memória	61
3.1 Políticas de preservação do patrimônio de Teresina	61
3.2 Inserção do Meduna como patrimônio	64
3.3 Venda do terreno, Criação do Rio Poty Shopping e Construções em andamento no terreno do Antigo Sanatório Meduna.....	75
3.4 Movimentos de Preservação	78
CONSIDERAÇÕES FINAIS	87
REFERÊNCIAS.....	88

INTRODUÇÃO

A forma como a sociedade compreende e aborda o tratamento da saúde mental tem passado por transformações profundas ao longo da história, refletindo mudanças filosóficas, científicas, políticas, culturais e sociais. As noções de “normalidade” e “diferença” nunca foram estáticas ou universais, sendo constantemente redefinidas de acordo com os valores, saberes e interesses predominantes em cada contexto histórico. Nesse sentido, o tratamento em saúde mental deve ser entendido como uma construção social que se manifesta não apenas nos discursos médicos e institucionais, mas também na materialidade dos espaços físicos destinados ao cuidado e ao isolamento.

Os locais destinados ao tratamento da saúde mental, em especial as instituições psiquiátricas, constituem materializações históricas desse processo. A arquitetura desses espaços não se limita a desempenhar uma função técnica ou funcional, mas participa ativamente da organização das práticas terapêuticas, da disciplina institucional e das relações de poder estabelecidas em seu interior. Ao longo do tempo, as tipologias arquitetônicas associadas à psiquiatria dialogaram diretamente com mudanças nos saberes médicos, nas políticas públicas de saúde e nos processos de urbanização, evidenciando a estreita relação entre saúde, sociedade e território.

É nesse contexto que se insere o estudo do edifício do antigo Sanatório Meduna, localizado em Teresina (PI), que constitui o objeto central das análises desenvolvidas nesta dissertação. Inaugurado em 1954, o Sanatório Meduna representou, à época, um marco na assistência psiquiátrica no Piauí, ao materializar um projeto médico e institucional alinhado aos discursos de modernização e humanização do tratamento em saúde mental vigentes no Brasil de meados do século XX. Paralelamente, sua implantação e trajetória acompanharam processos significativos de expansão e transformação urbana da cidade de Teresina, especialmente no entorno do rio Poti, revelando a articulação entre a instituição psiquiátrica, o crescimento da malha urbana e a produção do espaço da cidade.

A partir da análise histórica, arquitetônica e urbana do Sanatório Meduna, esta pesquisa busca compreender o edifício como expressão da memória e do patrimônio moderno, investigando seus valores históricos, simbólicos e arquitetônicos, bem como as transformações espaciais e territoriais que marcaram sua trajetória ao longo do



tempo. O trabalho problematiza ainda os desafios relacionados à preservação de edificações vinculadas à história da saúde mental, frequentemente submetidas a processos de esquecimento, desvalorização e substituição por novos empreendimentos no contexto das dinâmicas urbanas contemporâneas.

A pesquisa fundamenta-se em uma revisão teórica que articula estudos sobre psiquiatria, arquitetura, urbanismo, patrimônio e memória cultural, permitindo uma leitura integrada do edifício e de seu entorno urbano. Do ponto de vista metodológico, adota-se a combinação de estudo histórico-documental, análise arquitetônica e urbana e levantamento de informações, complementados por estudos de caso de instituições psiquiátricas implantadas em outras cidades brasileiras, que contribuem para a contextualização do Sanatório Meduna no panorama da arquitetura de instituições destinadas ao tratamento da saúde mental.

Dessa forma, esta dissertação visa contribuir para a compreensão do papel do Sanatório Meduna na construção da paisagem cultural de Teresina e para a reflexão crítica sobre os sentidos atribuídos à preservação, ou à perda, dos espaços associados ao tratamento em saúde mental. Ao articular arquitetura, cidade e memória, o trabalho reconhece essas edificações como documentos históricos e urbanos, fundamentais para o entendimento das relações entre identidade, patrimônio e transformação do espaço urbano.

A estrutura da dissertação organiza-se em três capítulos: o primeiro discute a evolução histórica dos espaços destinados ao tratamento em saúde mental; o segundo analisa o desenvolvimento urbano de Teresina e a trajetória histórica e arquitetônica do Sanatório Meduna; e o terceiro aborda as políticas de preservação patrimonial e os movimentos de memória relacionados ao edifício e à cidade.



CAPÍTULO 1: A EVOLUÇÃO DOS ESPAÇOS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO

1.1 Modernidade: Nascimento da psiquiatria e do manicômio psiquiátrico

A psiquiatria constitui-se como campo específico do saber médico na Europa entre o final do século XVIII e o início do século XIX, período marcado pelas transformações políticas, científicas e sociais associadas à modernidade. A partir da segunda metade do século XVIII, especialmente no contexto do Iluminismo, intensifica-se a valorização da racionalidade científica, do conhecimento técnico e da organização estruturada da vida social, criando condições para a redefinição da loucura como objeto de estudo médico (Foucault, 1978).

Até o século XVII, a loucura era predominantemente interpretada a partir de matrizes religiosas, morais ou jurídicas, sendo frequentemente associada ao desvio, ao pecado ou à marginalidade social. A partir do século XVIII, contudo, observa-se uma mudança significativa nesse entendimento. A loucura passa a ser progressivamente incorporada ao campo da medicina, sendo compreendida como condição passível de observação clínica, classificação diagnóstica e intervenção terapêutica. Esse deslocamento marca o início do processo de medicalização da loucura, que se consolida ao longo do século XIX (Foucault, 1978).

Entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, médicos e pensadores europeus passam a defender a necessidade de produzir conhecimento sobre os indivíduos considerados mentalmente enfermos. Nesse contexto, a loucura deixa de ser vista apenas como problema individual e passa a ser tratada como questão de interesse público, exigindo respostas institucionais permanentes. Conforme destaca Vieceli (2014, p. 56), é nesse período que a loucura se transforma em objeto de saber técnico-científico, articulando-se à criação de instituições especializadas.

A consolidação da psiquiatria moderna apoia-se, nesse momento, na elaboração de classificações das doenças mentais, na observação contínua dos pacientes e na organização de métodos terapêuticos orientados pela ciência médica. Esses procedimentos tornam-se progressivamente sistematizados ao longo do século XIX, contribuindo para a afirmação da psiquiatria como disciplina autônoma no interior da medicina.



É nesse contexto histórico que se delineia o manicômio como instituição específica. Ao longo do século XIX, o manicômio passa a ser concebido como espaço destinado à internação, observação e tratamento dos indivíduos diagnosticados como loucos, distinguindo-se de hospitais gerais, prisões ou antigos locais de reclusão indiferenciada. Para Foucault (1978), a institucionalização da loucura nesse período evidencia a estreita relação entre a produção do saber médico e as formas modernas de organização social.

Antes da consolidação dos manicômios como tipologia arquitetônica definida, processo que se intensifica ao longo do século XIX, já estavam estabelecidos os princípios institucionais que orientariam sua materialização. Desde o final do século XVIII, a psiquiatria nascente defendia a separação dos indivíduos considerados loucos do convívio urbano, a organização rigorosa das rotinas e a criação de ambientes controlados, entendidos como condições fundamentais para o tratamento. Nesse estágio, a preocupação central ainda não recaía sobre a forma arquitetônica acabada, mas sobre a constituição de uma ordem institucional racionalizada.

A noção moderna de confinamento, formulada nesse período, não se restringe ao isolamento físico, mas baseia-se na crença de que a regularidade do cotidiano, a disciplina e a previsibilidade dos comportamentos poderiam contribuir para a reorganização da vida psíquica. Como observa Pelbart (1989), essa racionalização do confinamento expressa a articulação entre saber médico e normatização social, característica do pensamento moderno.

Além disso, desde o final do século XVIII, o discurso psiquiátrico passou a associar o tratamento da loucura ao afastamento dos centros urbanos, valorizando ambientes considerados mais ordenados, silenciosos e controlados. Embora essas concepções se materializem plenamente apenas ao longo do século XIX, elas já se apresentam, nesse momento inicial, como princípios orientadores da institucionalização da loucura (Foucault, 1978).

Dessa forma, o nascimento da psiquiatria e do manicômio deve ser compreendido como um processo historicamente situado entre o final do século XVIII e o século XIX, resultante da convergência entre saber científico, institucionalização médica e novas formas de organização social. Esses fundamentos conceituais estabelecem as bases para a criação dos primeiros espaços arquitetônicos destinados à internação psiquiátrica.



1.2 Os primeiros espaços de manicômio psiquiátrico

Antes da consolidação do manicômio como tipologia arquitetônica específica, a institucionalização da loucura ocorreu, em grande medida, por meio da adaptação de espaços preexistentes. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, hospitais, casas de assistência e estabelecimentos de reclusão multifuncionais passaram a incorporar, de forma progressiva, a internação de indivíduos considerados loucos. Esses espaços, inicialmente destinados ao acolhimento de pobres, doentes, mendigos e prisioneiros, foram sendo ressignificados como locais de confinamento e observação da loucura, no contexto das chamadas “grandes internações”.

Nesse contexto, o Hospital de Bicêtre e o Hospital da Salpêtrière, ambos em Paris, constituem exemplos emblemáticos dessa transformação funcional. O Hospital de Bicêtre (Figura 01) foi fundado em 1634, nos arredores de Paris, como instituição multifuncional destinada ao acolhimento de populações marginalizadas. Ao longo do século XVIII, passou a abrigar de forma organizada indivíduos considerados loucos, inserindo-se no sistema de internamento analisado por Michel Foucault em *“História da loucura na idade clássica (1978)”*. Embora não tenha sido concebido originalmente para fins psiquiátricos, Bicêtre tornou-se um espaço central na observação e classificação da loucura.

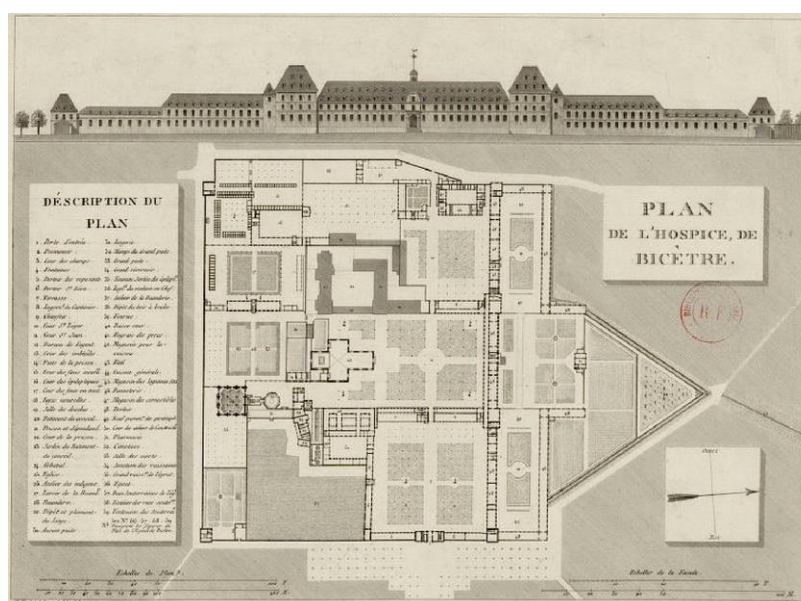


Figura 1 Planta Baixa do Hospital de Bicêtre.¹

¹ Fonte: Biblioteca Nacional da França (BnF).



De modo semelhante, o Hospital da Salpêtrière (Figura 02), criado em 1656 como parte do sistema de assistência e reclusão voltado principalmente para mulheres pobres e marginalizadas, passou a concentrar mulheres consideradas loucas ao longo dos séculos XVII e XVIII. A Salpêtrière consolidou-se, ainda no século XVIII, como um dos principais espaços de observação da loucura feminina, contribuindo para a formação do olhar médico e antecedendo a formalização do manicômio moderno no século XIX. Esses exemplos evidenciam que, antes da criação de edifícios especificamente projetados para a loucura, a institucionalização psiquiátrica operou por meio da adaptação e da reconfiguração de espaços existentes.

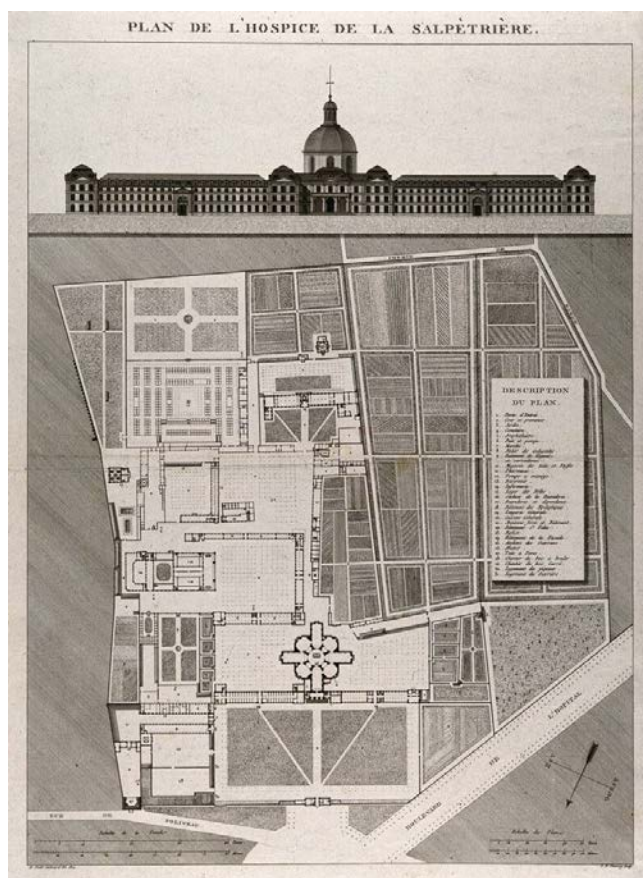


Figura 2 Planta Baixa do Hospital de Salpêtrière.²

A partir do século XIX, esse processo passa a se apoiar de forma estruturada em edifícios projetados desde a origem para a internação psiquiátrica. Nesse momento, o espaço destinado à loucura deixa de funcionar apenas como abrigo ou local

² Fonte: Biblioteca Nacional da França (BnF).



de reclusão e passa a funcionar como parte constitutiva do tratamento, articulando observação clínica, disciplina cotidiana e separação rigorosa dos internos. No contexto da modernidade, a psiquiatria, ao se afirmar como campo científico e como autoridade social, necessita estabelecer um lugar específico para o exercício de seu poder, e o manicômio se consolida como dispositivo institucional central desse processo (Foucault, 2010).

Essas instituições passaram a se estruturar segundo uma lógica espacial que respondia a duas exigências simultâneas: organizar a vida interna, rotinas, circulação, vigilância e setorização, e materializar a separação entre o espaço urbano considerado normativo e o espaço destinado aos indivíduos classificados como desviantes. Nesse contexto, consolida-se um modo de organizar o tempo e o espaço baseado na vigilância e na disciplina, no qual o controle dos corpos ocorre pela regulação minuciosa dos movimentos, dos percursos e das práticas institucionais (Foucault, 2010).

A tipologia arquitetônica que se difunde de forma mais consistente ao longo do século XIX é a pavilhonar. Baseada na fragmentação do conjunto em unidades relativamente autônomas, essa tipologia permitia classificar os internos por sexo, comportamento e critérios diagnósticos, além de facilitar a vigilância e o controle dos fluxos. A separação física entre pavilhões, associada a percursos controlados e a uma hierarquia espacial rigorosa, evidencia a arquitetura como instrumento ativo da prática psiquiátrica, e não como simples suporte funcional (Calmon, 1952).

A organização interna desses estabelecimentos revela uma hierarquia espacial clara: setores administrativos e médicos ocupam posições estratégicas; pavilhões de internos são distribuídos conforme critérios de gestão e classificação; e pátios internos funcionam como espaços de permanência e circulação supervisionada. A forma simétrica, a divisão em alas e a setorização do conjunto expressam arquitetonicamente uma ordem social projetada para o interior da instituição, materializando distinções explícitas entre diferentes perfis e condições de internação.

Um exemplo significativo da maturação dessa lógica pavilhonar é o Asilo de Alienados de Sainte-Anne (Figura 03 e 04), em Paris, cuja concepção evidencia a associação direta entre método médico e organização espacial. O plano segmentado e simétrico, a distribuição das unidades de classificação e a organização rigorosa da circulação demonstram como a arquitetura foi concebida como meio de tratamento,



no qual o próprio edifício passa a exercer função terapêutica ao garantir isolamento, ordem e clareza, transformando o asilo em um verdadeiro “remédio” espacial.



Figura 3 Asilo de Alienados de Sainte-Anne.³



Figura 4 Asilo de Alienados de Sainte-Anne em 1877.⁴

A passagem dos antigos espaços de reclusão para o asilo terapêutico, contudo, não significou a superação da contenção, mas sua reconfiguração. A contenção física

³ Fonte: Biblioteca Nacional da França (BnF).

⁴ *Idem.*



direta tende a ser substituída por contenções espaciais e administrativas, como regimes internos, hierarquias institucionais e percursos permitidos. Nessa perspectiva, o manicômio opera como um “lugar operador” de práticas de docilização, no qual o corpo é disciplinado para se tornar útil, previsível e obediente (Ribeiro, 2006). Mesmo quando associado ao discurso de humanização, o espaço manicomial manteve-se profundamente vinculado à lógica do confinamento.

Esses princípios arquitetônicos e institucionais, formulados no contexto europeu, foram progressivamente apropriados no Brasil a partir da segunda metade do século XIX. A implantação dos primeiros manicômios brasileiros ocorre em diálogo direto com esses modelos, inserida em um contexto marcado pelo higienismo, pela medicalização da vida urbana e pela busca de ordenação social. Instituições como o Hospício Pedro II, no Rio de Janeiro, e o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em São Paulo, integram esse processo mais amplo de difusão do modelo manicomial no país, ao lado de outros espaços implantados em diferentes regiões.

No contexto brasileiro, a organização espacial dessas instituições manteve características fundamentais do modelo asilar, como o isolamento territorial, a separação rigorosa dos internos e a administração disciplinar do cotidiano. Ao longo do final do século XIX e início do século XX, reformas sanitárias e reorganizações institucionais buscaram adequar esses espaços às novas exigências médicas, sem romper com a lógica de confinamento que estruturava o modelo manicomial. Assim, a arquitetura dos primeiros manicômios no Brasil deve ser compreendida como resultado da adaptação local de modelos internacionais, nos quais o espaço construído desempenhou papel central na organização do cuidado, da disciplina e do isolamento da loucura.

1.3 Estudo de Caso: Hospício Pedro II (RJ)

O Hospício Pedro II (Figura 05) foi inaugurado em 1852, no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, constituindo a primeira instituição pública destinada exclusivamente ao atendimento de pessoas com transtornos mentais no país. Sua criação insere-se no contexto das reformas médicas e administrativas do século XIX, período marcado pela consolidação do alienismo como campo científico e pela ampliação da atuação do Estado na assistência e no controle dos indivíduos considerados desviantes da ordem social (Teixeira; Ramos, 2012). Nesse sentido, o hospício não



se configura apenas como resposta médica à loucura, mas como parte de um projeto mais amplo de ordenação social e urbana.



Figura 5 Hospício Pedro II. Litogravura de Pieter Godfred Bertichen, século XIX.⁵

A fundação do Hospício Pedro II esteve diretamente associada ao projeto de modernização do Império, que buscava alinhar o Brasil às práticas científicas e institucionais europeias, especialmente francesas. Conforme analisa Viecele (2014), a criação de instituições psiquiátricas específicas representava um passo fundamental para a afirmação da psiquiatria como saber legítimo e autoridade social. Inspirado nos princípios da chamada terapia moral, o hospício incorporou a ideia de que o isolamento do paciente, a disciplina cotidiana e a organização racional do espaço eram condições essenciais para o tratamento.

A escolha do sítio para sua implantação materializa essas concepções. Localizado na região da Praia Vermelha, área então relativamente afastada do núcleo urbano consolidado, o edifício reforçava a separação física entre a cidade e o espaço

⁵ Fonte: Biblioteca Nacional da França (BnF).



destinado à loucura. Esse afastamento não respondia apenas a critérios médicos, mas também a preocupações morais e administrativas, ao retirar da vida urbana indivíduos considerados indesejáveis à ordem social vigente (Teixeira; Ramos, 2012).

Desde seus primeiros anos de funcionamento, o Hospício Pedro II estruturou-se como espaço de observação clínica, classificação diagnóstica e administração dos internos. A separação dos pacientes por sexo, tipo de transtorno e comportamento refletia a adoção das diretrizes da psiquiatria europeia oitocentista e respondia à necessidade de controle de um número crescente de internos. Como observa Viecei (2014), essas práticas evidenciam a ambiguidade do hospício: simultaneamente espaço de cuidado médico e de confinamento prolongado.

Do ponto de vista arquitetônico, o Hospício Pedro II representa a primeira materialização, em escala institucional, do modelo manicomial no Brasil. Sua organização espacial não se limitava a abrigar as práticas médicas, mas operava como parte integrante do próprio tratamento. A arquitetura traduzia em forma construída os princípios da disciplina institucional, organizando rotinas, delimitando comportamentos e estruturando hierarquias internas.

O edifício foi organizado segundo uma lógica pavilhonar, com setores destinados à internação, aos serviços médicos, à administração e às áreas de convivência. Essa fragmentação do conjunto arquitetônico permitia a separação física dos internos conforme critérios clínicos e morais, ao mesmo tempo em que favorecia a vigilância contínua e a administração cotidiana. A hierarquização dos espaços institucionais expressava, de forma concreta, as relações de poder que atravessavam a prática psiquiátrica (Viecei, 2014).

Pátios internos, jardins e áreas abertas integravam o conjunto arquitetônico e desempenhavam papel relevante no funcionamento do hospício. Esses espaços eram destinados à circulação supervisionada, à permanência coletiva e a atividades consideradas terapêuticas, reforçando a concepção de que o ambiente físico poderia atuar sobre o comportamento dos internos. O contato controlado com o exterior era entendido como parte do processo de tratamento, ainda que rigidamente regulado pela instituição (Viecei, 2014).

A circulação interna do hospício foi cuidadosamente planejada para estabelecer limites claros entre os diferentes setores e restringir a mobilidade dos internos



conforme sua condição clínica. Corredores, acessos e percursos internos funcionavam como mecanismos de controle espacial, transferindo parte da vigilância para a própria configuração do edifício (Figura 06). Nesse sentido, o Hospício Pedro II pode ser compreendido como um dispositivo arquitetônico no qual espaço e poder se articulam de forma indissociável (Pessotti, 2002).

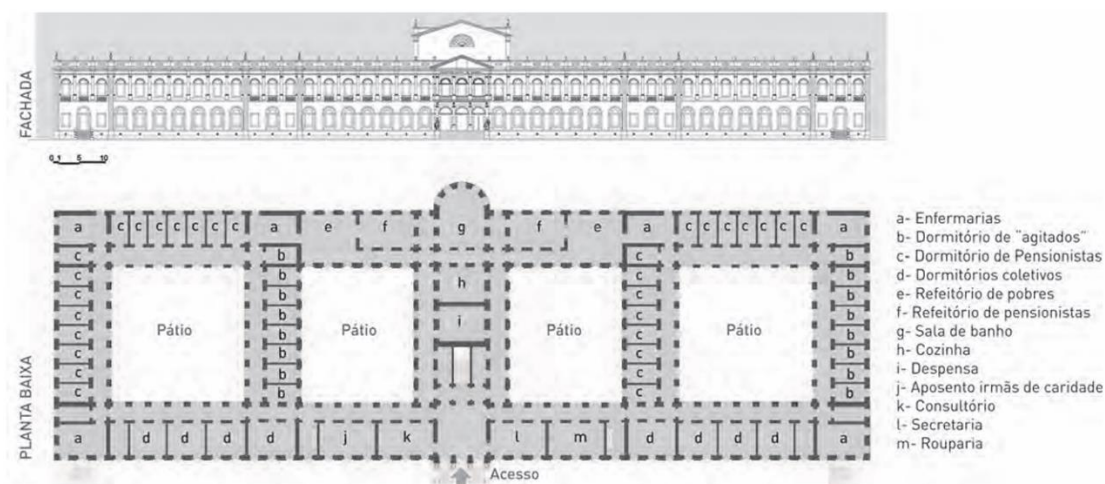


Figura 6 Hospício Pedro II. Planta baixa e fachada.⁶

Ao longo da segunda metade do século XIX, o hospício passou por sucessivas ampliações e adaptações físicas para responder ao crescimento da demanda por internações psiquiátricas no Rio de Janeiro. Essas transformações evidenciam tanto a expansão do alienismo no Brasil quanto os limites do modelo manicomial, que passou a enfrentar problemas recorrentes de superlotação, precarização das condições internas e permanência prolongada dos pacientes, afastando-se progressivamente do ideal terapêutico originalmente defendido (Vieceli, 2014).

A partir do início do século XX, o Hospício Pedro II perdeu gradualmente sua centralidade no sistema de assistência psiquiátrica da cidade, em paralelo às mudanças nas políticas de saúde e à criação de novas instituições especializadas. O encerramento de suas atividades como hospital psiquiátrico, na década de 1940, marcou o fim de sua função original enquanto espaço de confinamento e tratamento da loucura.

Posteriormente, o edifício foi incorporado ao patrimônio da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), passando a integrar o

⁶ VIECELI, Ana Paula. **Lugares da loucura**: arquitetura e cidade no encontro com a diferença. 2014, p. 70.



campus da Praia Vermelha (Figura 07). Atualmente conhecido como Palácio Universitário, o antigo hospício abriga atividades acadêmicas, administrativas e culturais, configurando um processo de reutilização adaptativa que assegurou a permanência física do conjunto arquitetônico e sua integração ao tecido urbano contemporâneo.



Figura 7 Antigo Hospício Pedro II, atual Palácio Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Praia Vermelha.⁷

A trajetória do Hospício Pedro II, desde sua implantação como primeira instituição psiquiátrica do país até sua incorporação ao espaço universitário, permite compreender como edificações originalmente associadas à assistência psiquiátrica acumulam camadas de significado ao longo do tempo. Mais do que um exemplo isolado, o edifício revela as tensões entre cuidado, disciplina e exclusão que marcaram a institucionalização da loucura no Brasil, permanecendo como referência arquitetônica e histórica na paisagem urbana do Rio de Janeiro.

1.4 Hospital Psiquiátrico do Juqueri (SP)

O Hospital Psiquiátrico do Juqueri (Figura 08) foi inaugurado em 1898, no território que viria a constituir o município de Franco da Rocha, no estado de São Paulo.

⁷ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Divisão de Memória Institucional. Acesso em: 10 maio 2025.



Sua implantação insere-se no contexto das transformações urbanas e sanitárias ocorridas no final do século XIX, período marcado pela consolidação de políticas públicas voltadas à assistência psiquiátrica e pela incorporação de modelos institucionais europeus ao cenário brasileiro.



Figura 8 Vista externa do antigo Asilo de Alienados do Juqueri.⁸

Naquele período, a escolha do sítio para a implantação do hospital esteve diretamente relacionada à expansão da malha ferroviária paulista. A proximidade com a Estrada de Ferro Santos, em Jundiaí, operada pela São Paulo Railway⁹, foi determinante para a localização do Juqueri, pois permitia o deslocamento relativamente rápido entre a capital paulista e a instituição, ao mesmo tempo em que assegurava o afastamento físico necessário ao funcionamento do hospital psiquiátrico (Silva, 1996). Segundo a autora, a ferrovia desempenhou papel central na viabilização logística do complexo, possibilitando o transporte de pacientes, funcionários, materiais de construção e suprimentos indispensáveis à manutenção cotidiana da instituição (Figura 09).

⁸ Fonte: Universidade de São Paulo (USP). Biblioteca Central da POLI-USP.

⁹ A São Paulo Railway Company foi uma empresa ferroviária de capital inglês, responsável pela construção e operação da Estrada de Ferro Santos, em Jundiaí, inaugurada em 1867. A ferrovia teve papel fundamental na integração entre o interior paulista e o porto de Santos, sendo decisiva para a expansão econômica, urbana e industrial do estado de São Paulo no final do século XIX e início do século XX.



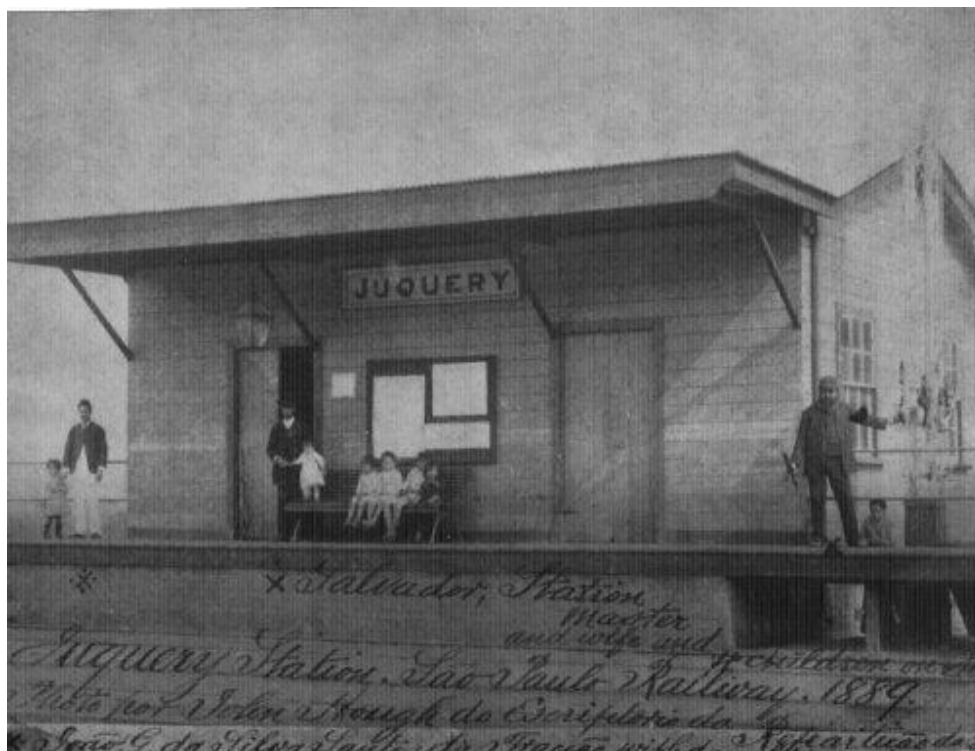


Figura 9 Antiga Estação Juquery, inaugurada em 1888 pela São Paulo Railway, atualmente estação Franco da Rocha.¹⁰

O território onde o hospital foi implantado apresentava, no final do século XIX, características predominantemente rurais, com baixa densidade populacional e extensas áreas disponíveis. Essa condição favoreceu a adoção de um modelo institucional compatível com as concepções médicas vigentes, que associavam o isolamento espacial, a disciplina cotidiana e o contato controlado com a natureza a fatores positivos no tratamento da loucura. O afastamento do núcleo urbano consolidado atendia, assim, tanto a critérios funcionais quanto simbólicos, reforçando a separação entre o espaço da cidade e o espaço destinado aos indivíduos considerados doentes mentais (Rosa, 2011).

A implantação do Hospital Psiquiátrico do Juqueri exerceu papel decisivo na organização territorial da região. De acordo com Silva (1996), o hospital e a estação ferroviária constituíram os principais elementos estruturadores do núcleo urbano que daria origem ao município de Franco da Rocha, configurando o que a autora denomina

¹⁰ Fonte: Universidade de São Paulo (USP). Biblioteca Central da POLI-USP.



“binômio ferrovia–hospício”. A presença da instituição estimulou a formação de moradias, serviços e atividades econômicas vinculadas ao seu funcionamento, fazendo com que o hospital assumisse centralidade na produção do espaço local.

Além da acessibilidade ferroviária, aspectos ambientais também influenciaram a escolha do sítio. A topografia suave, a disponibilidade de recursos hídricos e a existência de amplas áreas livres possibilitaram a implantação de um conjunto hospitalar pavilhonar, com jardins, pátios e áreas destinadas às atividades agrícolas. Segundo Costa (2018), essas características estavam diretamente associadas às práticas terapêuticas vigentes, que incorporavam o trabalho e o contato com o ambiente natural como instrumentos simultâneos de ocupação, disciplina e tratamento dos internos.



Figura 10 Detalhe do Asilo de Alienados do Juqueri, projetado por Ramos de Azevedo em 1898.¹¹

Nos anos que se seguiram à sua implantação, o Hospital Psiquiátrico do Juqueri passou por um processo acelerado de expansão institucional, motivado pela crescente demanda por atendimento psiquiátrico no estado de São Paulo. Já nos primeiros anos do século XX, a capacidade inicialmente prevista mostrou-se insuficiente diante do aumento contínuo das internações, o que levou à ampliação progressiva do número de pavilhões e à expansão física do complexo hospitalar (Silva, 1996).

¹¹ Fonte: Universidade de São Paulo (USP). Biblioteca Central da POLI-USP.



A partir de 1903, sob a direção de Francisco Franco da Rocha, o Hospital Psiquiátrico do Juqueri passou por uma reorganização institucional orientada pelos princípios científicos então vigentes. Ao longo das duas décadas em que esteve à frente da instituição, Franco da Rocha estruturou o hospital como centro de referência psiquiátrica, implementando critérios de classificação diagnóstica, separação dos internos por sexo e tipologia clínica e regulamentação rigorosa das rotinas institucionais (Rosa, 2011).

Entre 1903 e as primeiras décadas do século XX, o Juqueri experimentou crescimento acelerado de sua população interna, impulsionado pelo aumento demográfico do estado e pela ampliação das políticas de internação compulsória. Nesse período, o hospital consolidou-se como principal destino para o encaminhamento de indivíduos considerados “alienados”, provenientes tanto da capital quanto do interior paulista, reforçando seu caráter centralizador (Rosa, 2011).

Já em 1918, a instituição apresentava uma estrutura complexa, composta por múltiplos pavilhões especializados, setores administrativos, oficinas e extensas áreas agrícolas. Conforme analisa Silva (1996), a expansão das atividades produtivas internas esteve diretamente associada à adoção da laborterapia, concebida simultaneamente como prática terapêutica e estratégia de sustentação do próprio complexo hospitalar.

Na década de 1920, o Hospital Psiquiátrico do Juqueri consolidou-se como o maior complexo psiquiátrico do país, funcionando como uma verdadeira cidade hospitalar, dotada de infraestrutura própria e relativa autonomia em relação ao meio urbano externo (Costa, 2018). Ainda que sustentado por discursos médicos e científicos, esse crescimento intensificou práticas de controle, vigilância e segregação, evidenciando os limites do modelo manicomial, no qual a racionalidade terapêutica coexistia com processos de exclusão social e institucionalização permanente (Rosa, 2011).

Do ponto de vista arquitetônico, a organização do Hospital Psiquiátrico do Juqueri materializou os princípios do modelo manicomial-pavilhonar adotado pela psiquiatria brasileira no início do século XX. O projeto arquitetônico do complexo foi elaborado pelo arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, em estreita articulação com o médico psiquiatra Francisco Franco da Rocha, responsável pela concepção institucional e terapêutica da iniciativa.



Sob a orientação médico-científica de Franco da Rocha, Ramos de Azevedo adotou como referência modelos europeus de arquitetura hospitalar psiquiátrica do século XIX, especialmente o Asilo de Alienados de Sainte-Anne, em Paris, e o Asilo-Colônia de Alt-Scherbitz, na Alemanha. A incorporação da lógica pavilhonar refletia a compreensão de que o espaço construído deveria operar como parte ativa do tratamento, permitindo a separação dos internos por sexo, diagnóstico e comportamento, além de favorecer a vigilância, a circulação controlada e a administração institucional (Rossa, 2011; Silva, 1996).

A partir dessa concepção, o conjunto passou a ser composto por pavilhões independentes, implantados de maneira dispersa no terreno, cada qual destinado a funções específicas, como internação, administração, serviços médicos e atividades produtivas, configurando uma hierarquia espacial coerente com os princípios disciplinares e terapêuticos do modelo asilar.

A implantação dos pavilhões seguiu uma hierarquia espacial clara, na qual os setores administrativos e médicos ocupavam posições estratégicas, enquanto os pavilhões de internação se distribuíam de forma mais afastada entre si. Conforme analisa Silva (1996), essa organização facilitava o controle dos fluxos internos e reforçava a vigilância institucional, transferindo parte do controle para a própria configuração do espaço construído.

A circulação interna do complexo foi estruturada por meio de caminhos e eixos que conectavam os diferentes pavilhões, permitindo deslocamentos supervisionados e restringindo a mobilidade dos internos conforme sua condição clínica. Segundo Rosa (2011), o desenho desses percursos contribuía para estabelecer limites claros entre os setores, reforçando a disciplina institucional e a separação funcional dos espaços (Figura 11 e 12).



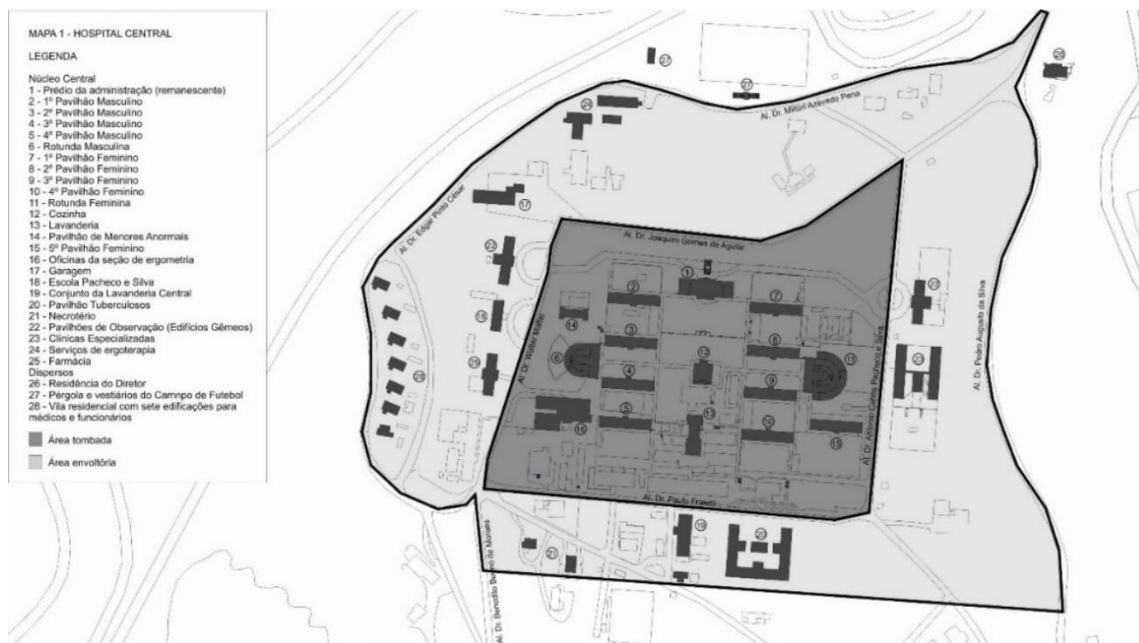


Figura 11 Mapa do Hospital Central do Juquery.¹²



Figura 12 Vista aérea do Complexo Hospitalar do Juquery.¹³

¹² PINHEIRO, Caroline Campos. **Presente e passado do Complexo Hospitalar do Juquery: uma análise do uso do espaço ao longo do tempo**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Turismo) – Universidade de São Paulo, 2022.

¹³ Google Earth.



Os pátios e áreas abertas assumiram papel fundamental na organização espacial do hospital, funcionando como espaços intermediários entre os pavilhões. Conforme analisa Costa (2018), esses ambientes eram utilizados para permanência coletiva, circulação e atividades terapêuticas ao ar livre, articulando visibilidade, controle e convivência supervisionada. A relação entre edifícios e espaços livres reforçava o caráter disciplinar do conjunto, ao mesmo tempo em que atendia às concepções médicas que valorizavam o contato com o ambiente externo.

Durante o processo de esvaziamento institucional do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, episódios de degradação física e fragilização da gestão do complexo tornaram-se cada vez mais evidentes. Um marco simbólico desse processo ocorreu na madrugada de 17 de dezembro de 2005, quando o prédio da antiga administração central foi parcialmente destruído por um incêndio. O episódio evidenciou o estado de abandono progressivo significativo do conjunto edificado e expôs a vulnerabilidade patrimonial de uma das mais importantes instituições da psiquiatria brasileira.

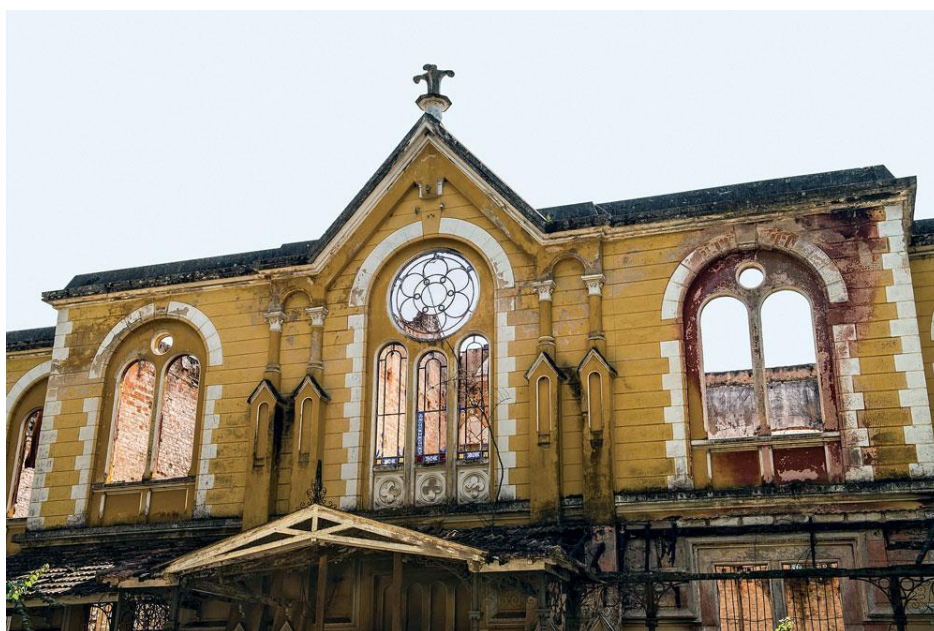


Figura 13 Detalhe do Prédio da diretoria após o incêndio de 2005.¹⁴

Nesse contexto de risco material e de desativação funcional, o Complexo Hospitalar do Juqueri foi reconhecido como bem cultural de relevante valor histórico, ar-

¹⁴ Eduardo Cesar. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/atelie-juquery/>.



quitetônico, urbanístico e paisagístico, sendo tombado em 2011 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT). O processo de tombamento, iniciado ainda em 1986, foi concluído após 25 anos de tramitação, revelando as tensões e dificuldades inerentes ao reconhecimento patrimonial de instituições vinculadas ao modelo asilar.

O tombamento destacou especialmente a implantação do conjunto, a harmonia da composição pavilhonar, o paisagismo e os jardins remanescentes, bem como a relevância das obras projetadas por Ramos de Azevedo, reconhecendo o Juqueri como marco histórico da medicina, da psiquiatria e das políticas de saúde pública no estado de São Paulo.

A desativação das funções asilares do Juqueri prosseguiu de forma gradual. Em 1º de abril de 2021, foram oficialmente encerradas as internações psiquiátricas de longa permanência, com a transferência dos últimos residentes que ainda viviam no complexo, marcando o fim de mais de 122 anos de funcionamento contínuo do hospital como espaço de confinamento asilar. Esse encerramento insere-se no processo de implementação das diretrizes da Reforma Psiquiátrica no Brasil, orientada pela Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, e evidencia a transformação institucional do Juqueri no século XXI.

Como observa Rosa (2011), a desativação de grandes hospitais psiquiátricos no Brasil frequentemente ocorre dissociada de políticas amplas e integradas de memória, o que dificulta a incorporação dessas experiências ao debate urbano, patrimonial e historiográfico contemporâneo. No caso do Juqueri, embora o tombamento tenha assegurado a preservação formal de partes significativas do conjunto, a resignificação social e simbólica do território permanece marcada por iniciativas pontuais e desiguais.

Nesse cenário, destaca-se o Museu de Arte Osório Cesar como uma das principais ações de preservação e ativação da memória do antigo complexo hospitalar. O museu foi instalado em edificação que originalmente abrigava a residência do diretor do hospital, construída segundo referências do *chalet* francês, volumetria diferenciada e caráter arquitetônico distinto dos pavilhões de internação. Essa edificação integrava o conjunto do Juqueri como espaço residencial vinculado à hierarquia institucional, evidenciando a coexistência, no território asilar, de funções assistenciais, administrativas e habitacionais.





Figura 14 Casa do Diretor inspirada no Chalet francês.¹⁵

Atualmente, o Museu de Arte Osório Cesar abriga, preserva e difunde a produção artística realizada por internos do hospital, associada à trajetória do psiquiatra Osório Cesar, constituindo um dos principais núcleos de preservação da memória institucional do Juqueri. Conforme analisa Ribeiro (2016), a transformação da antiga residência em espaço museológico representa uma estratégia de ressignificação que, ao mesmo tempo em que valoriza a produção artística vinculada à experiência manicomial, seleciona fragmentos específicos da memória do complexo.



Figura 15 Museu Osório César, 2024.¹⁶

¹⁵ Fonte: Foto Iná Rosa, dezembro de 2010.

¹⁶ Fonte: Foto Ana Elisa Miranda, setembro de 2024.



Além de sua função museológica, o edifício passou a integrar o cotidiano urbano de Franco da Rocha como espaço cultural e área de convivência, evidenciando o potencial de reuso de edificações historicamente associadas ao confinamento, sem, contudo, eliminar as tensões inerentes à preservação de um território marcado pela institucionalização da loucura.

1.5 Estudo de Caso: Hospital psiquiátrico Philippe Pinel (SP)

O Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, localizado no bairro de Pirituba, na zona noroeste da cidade de São Paulo, foi fundado em 1922 e inaugurado em 1929, em um contexto de crescente demanda por leitos psiquiátricos no estado, decorrente do processo acelerado de urbanização e da insuficiência das instituições públicas existentes, em especial o Hospital do Juquery. Diferentemente deste, o Pinel foi concebido como uma instituição privada, voltada a pacientes das classes média e alta, funcionando mediante pagamento de mensalidades, o que influenciou diretamente sua escala, implantação e organização espacial (Couto, 1999; Lanzellotti, 2016).



Figura 16 Hospital psiquiátrico Philippe Pinel, em 1929.¹⁷

A criação do sanatório esteve diretamente associada à atuação do médico psiquiatra Antônio Carlos Pacheco e Silva, figura central da psiquiatria paulista nas primeiras décadas do século XX. Antônio Pacheco havia assumido a direção do Hospital

¹⁷ Autor desconhecido. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/coluna/memoria/sanatorio-pirituba/>



do Juquery em 1923 e, paralelamente, desenvolvia uma intensa produção intelectual vinculada às ideias da higiene mental, amplamente difundidas no Brasil a partir da década de 1920. Conforme aponta Couto (1999), o Pinel constituiu-se como um espaço privilegiado para a experimentação de práticas terapêuticas consideradas modernas, em consonância com instituições estrangeiras observadas pelo médico, especialmente nos Estados Unidos.

Do ponto de vista territorial, a implantação do Hospital Philippe Pinel diferenciava-se de outros estabelecimentos psiquiátricos do período por sua inserção relativamente próxima ao tecido urbano em expansão, ainda que em uma área então caracterizada por baixa densidade construtiva e predominância de grandes glebas. O terreno fazia parte da antiga Fazenda Anastácio, em uma região marcada por áreas verdes e uso rural, condição que permitia certo isolamento funcional sem o afastamento extremo observado em complexos como o Juquery (Lanzellotti, 2016). Essa localização intermediária reflete uma transição na lógica de implantação dos hospitais psiquiátricos, já inseridos no processo de crescimento da cidade de São Paulo.



Figura 17 Área do Hospital psiquiátrico Philippe Pinel.¹⁸

Do ponto de vista arquitetônico, o Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel apresenta uma escala menor quando comparado aos grandes complexos asilares do final do século XIX e início do século XX. A análise da vista aérea do conjunto evidencia uma

¹⁸ Google Earth, acesso em novembro 2025.



implantação fragmentada, composta por edifícios de pequeno e médio porte distribuídos em meio a uma área densamente arborizada, inserida no tecido urbano.

O espaço apresenta fachada de caráter neocolonial (Figura 18), com composição marcada pela simetria, acesso central e ornamentação contida, elementos recorrentes na arquitetura institucional das primeiras décadas do século XX em São Paulo. Do ponto de vista formal, essa solução aproxima-se de estratégias arquitetônicas observadas no Sanatório Meduna, sobretudo na adoção de uma linguagem eclética, na centralidade do acesso e na busca por uma imagem arquitetônica organizada, adequada à função assistencial.



Figura 18 Fachada do Hospital psiquiátrico Philippe Pinel.¹⁹

A leitura da implantação sugere uma apropriação parcial da lógica pavilhonar, sem a adoção integral do modelo clássico. Os volumes laterais, aparentemente independentes do corpo central, indicam uma setorização funcional básica, embora não seja possível afirmar, a partir das imagens disponíveis, a destinação específica de cada bloco.

Essa conformação espacial está diretamente relacionada ao perfil institucional do hospital. Como destaca Lanzellotti (2016), o Pinel foi concebido como um sanatório

¹⁹ Autor desconhecido. Disponível em: <https://www.ipatrimonio.org/>



moderno, voltado à aplicação de práticas terapêuticas inovadoras, como a laborterapia, atividades ao ar livre e o conceito de *open-door*²⁰, no qual parte dos pacientes podia circular livremente pela área do hospital. Ainda que essas práticas não impliquem, necessariamente, uma arquitetura aberta nos moldes dos grandes complexos, elas demandavam espaços externos, áreas livres e uma relação controlada entre edifício e terreno, perceptível na implantação do conjunto.

Ao longo do século XX, o Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel manteve sua função assistencial, passando por adaptações e reformas pontuais, acompanhando as transformações das políticas de saúde mental no Brasil. Diferentemente de instituições como o Juquery, o Pinel não foi integralmente desativado, permanecendo em funcionamento e sendo progressivamente incorporado à rede pública de saúde (Figura 00).



Figura 19 Hospital psiquiátrico Philippe Pinel, em 1929.²¹

²⁰ Conceito adotado em algumas instituições psiquiátricas a partir das primeiras décadas do século XX, especialmente em experiências europeias e norte-americanas, que defendia a redução do confinamento físico direto, com eliminação ou flexibilização de trancas, grades e celas, permitindo maior liberdade de circulação dos pacientes dentro do perímetro institucional.

²¹ GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Saúde. Localização: *CAISM Philippe Pinel*. São Paulo, s.d. Disponível em: <https://saude.sp.gov.br/caism-philippe-pinel/homepage/acesso-rapido/localizacao>. Acesso em: 10 janeiro 2026.



Em reconhecimento ao seu valor histórico, arquitetônico e simbólico, o conjunto foi tombado pelo CONDEPHAAT por meio do Processo nº 56.409/2007, com Resolução de Tombamento publicada em 2018. O tombamento destaca o hospital como testemunho material de uma fase específica da psiquiatria paulista, marcada pela iniciativa privada, pela influência do pensamento higienista e pela adoção de soluções arquitetônicas.

A análise do Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel evidencia, portanto, um modelo singular no panorama da arquitetura psiquiátrica brasileira. Sua implantação compacta, linguagem eclética, inserção urbana e organização espacial diferenciada o afastam das tipologias extensivas e rurais predominantes no final do século XIX, configurando um caso relevante para a compreensão das múltiplas formas de materialização da psiquiatria no espaço construído. Essas características tornam o Pinel um contraponto fundamental aos demais estudos de caso analisados, contribuindo para uma leitura mais complexa e plural da relação entre arquitetura, cidade e loucura no Brasil.



CAPÍTULO 2: O CONTEXTO HISTÓRICO DE TERESINA E O SANATÓRIO MEDUNA

2.1 Desenvolvimento Urbano de Teresina

Núcleo Histórico do Rio Parnaíba até o início do século XX

A cidade de Teresina foi fundada em 16 de agosto de 1852 com o propósito de substituir Oeiras como sede administrativa da província do Piauí, articulando um novo centro político e administrativo capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico e a integração territorial do estado. Diferentemente de grande parte das cidades brasileiras do período, cujo crescimento foi marcado por processos espontâneos e pouco planejados, Teresina nasce vinculada a um projeto urbano deliberado.

Conforme analisam Nunes e Abreu (1996), sua implantação foi orientada por um traçado geométrico regular, composto por vias retilíneas que se cruzam ortogonalmente, configurando o conhecido “tabuleiro de damas” e expressando a intenção de construir uma cidade ordenada desde sua origem (Figura 20). Esse caráter planejado se consolidaria ao longo do tempo com a incorporação de infraestruturas estratégicas, como a Estação Ferroviária de Teresina, e, já no século XXI, com instrumentos de planejamento como o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), que reinterpreta e atualizam essa lógica de organização urbana.

No final do século XIX e início do século XX, o crescimento da cidade ocorreu de forma relativamente ordenada, com o centro urbano estruturado. A proximidade do rio Parnaíba garantiu o abastecimento de água, servindo tanto para consumo quanto para atividades produtivas. Além disso, o rio era essencial para o deslocamento de pessoas, pois a rede viária ainda era limitada. Pequenos portos e embarcadouros foram instalados ao longo de sua margem, promovendo a conexão entre o núcleo central da cidade e comunidades ribeirinhas.



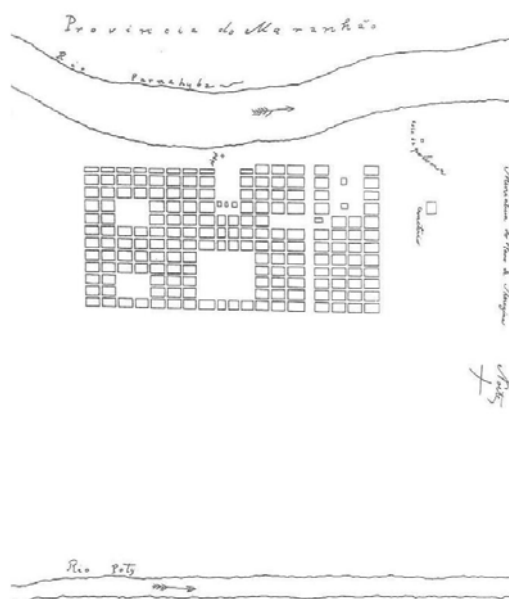


Figura 20 Miniatura do Plano de Teresina, esboço do Mestre Isidoro.²²

Entretanto, a dependência exclusiva do rio como principal meio de transporte também apresentava desafios. As cheias sazonais do Parnaíba frequentemente alagavam áreas urbanas e dificultavam o crescimento da cidade. Durante o período chuvoso, bairros próximos ao rio ficavam vulneráveis a inundações, prejudicando a infraestrutura e a ocupação urbana. Esse fator começou a influenciar o planejamento urbano, levando o poder público a buscar novas soluções para a expansão da cidade em direção a áreas mais elevadas.

Ocupação do Espaço Urbano antes da Ponte JK (1940-1957)

A partir da década de 1930, no contexto mais amplo da Era Vargas, políticas de modernização e fortalecimento do papel do Estado passaram a priorizar obras de infraestrutura e a ampliação do transporte terrestre no Brasil, orientação que se intensificou durante o Estado Novo (1937–1945). Embora essas diretrizes tenham sido formuladas em escala nacional, seus efeitos também se fizeram sentir em capitais regionais como Teresina, onde investimentos públicos na pavimentação de ruas e avenidas e na organização da circulação terrestre começaram a reduzir gradativamente a

²² Fonte: Acervo do Museu do Piauí.



dependência do transporte fluvial. Esse deslocamento dos eixos de mobilidade contribuiu para uma descentralização econômica da cidade, até então fortemente vinculada às atividades ligadas ao rio Parnaíba, abrindo espaço para novas centralidades articuladas às vias terrestres e aos bairros em expansão (Medeiros, 2019).

Na década de 1940, o desenvolvimento urbano de Teresina passou a ser pensado de forma mais estruturada, com investimentos do poder público na construção de pontes e na ampliação do sistema viário. Esse movimento esteve associado à consolidação de eixos terrestres de circulação, que passaram a organizar a expansão para além do núcleo histórico vinculado ao rio Parnaíba. Nesse período, a Avenida Frei Serafim (Figura 21) já se afirmava como o principal eixo urbano da cidade, articulando o centro consolidado e orientando novas frentes de ocupação, ao mesmo tempo em que recebia intervenções de urbanização que reforçavam seu papel estruturador na malha urbana. Paralelamente, a Avenida Miguel Rosa começava a ganhar relevância como eixo longitudinal ligado ao traçado da ferrovia, funcionando como via de conexão entre o centro e áreas situadas ao norte do núcleo histórico.



Figura 21 Avenida Frei Serafim na década de 1940.²³

²³ PORTAL CIDADE VERDE. *Avenida Frei Serafim na década de 1940*. Disponível em: <https://cidadeverde.com>. Acesso em: 17 agosto 2025.



Essas duas avenidas, Frei Serafim e Miguel Rosa (Figura 22), constituíam, ainda nos anos 1940, referências fundamentais para a organização dos fluxos terrestres e para a direção do crescimento urbano, favorecendo a expansão para além do centro e estimulando a formação de novos bairros nas zonas Norte e Sul. Nesse contexto, avançaram a ocupação em direção a Mafuá, Vila Operária, Vila Militar, Feira de Amostra e Matadouro, enquanto Cabral e Ilhotas se consolidavam como periferia imediata da área central (Moreira, 1979, p. 20).

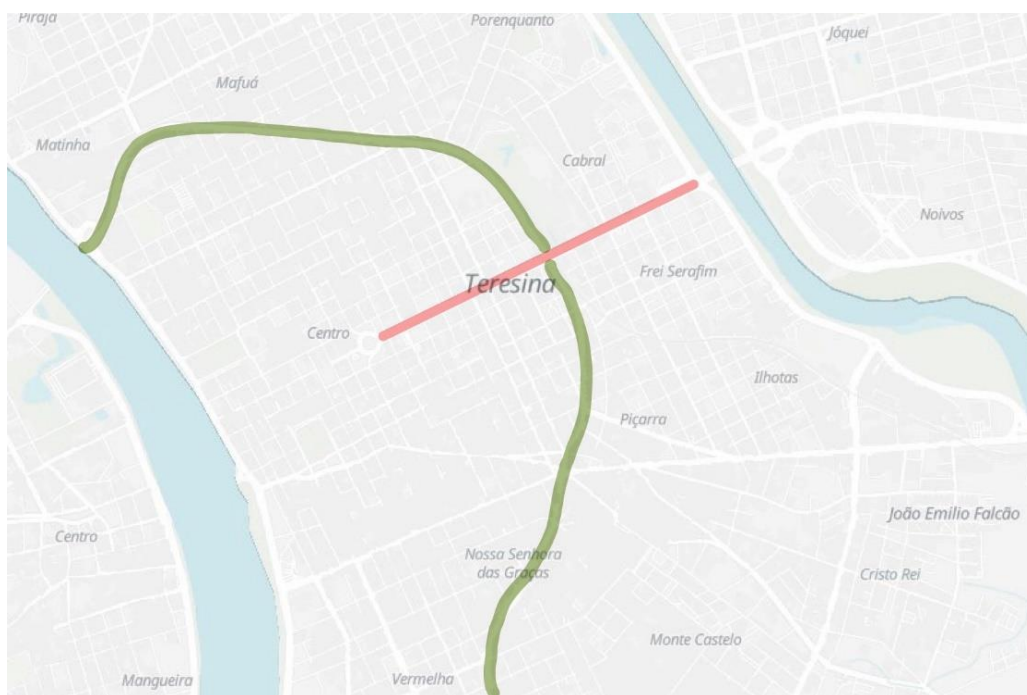


Figura 22 Mapa da cidade de Teresina com modificações feitas pela autora destacando Avenida Frei Serafim e Avenida Miguel Rosa.²⁴

A partir da década de 1950, o crescimento populacional começou a pressionar o limite das áreas já ocupadas no núcleo central, tornando mais evidente a necessidade de novas frentes de expansão urbana. Esse processo, contudo, ainda se dava predominantemente dentro da lógica de ocupação estabelecida nas décadas anteriores, orientada pelos eixos viários já consolidados e pelos vetores de crescimento para as zonas Norte e Sul.

Nesse contexto, observou-se um aumento gradual no número de instituições públicas e privadas instaladas fora do centro histórico. Escolas, hospitais e edifícios

²⁴ Fonte: Google Maps, adaptado pela autora, 2026.



administrativos passaram a se localizar em áreas um pouco mais afastadas do núcleo original, indicando os primeiros sinais de desconcentração funcional da cidade. Paralelamente, começaram a surgir iniciativas iniciais de planejamento urbano voltadas sobretudo à regulamentação do parcelamento do solo e à organização da malha viária nas áreas de expansão.

A valorização imobiliária tornou-se mais perceptível na primeira metade da década de 1950, à medida que novas vias eram abertas e que áreas antes pouco ocupadas passavam a despertar interesse do mercado. Como resultado, alguns bairros começaram a crescer para além do núcleo central, delineando um padrão de expansão que ganharia maior intensidade apenas nas décadas seguintes.

A ampliação gradual da infraestrutura básica, especialmente abastecimento de água, eletrificação e serviços urbanos, também contribuiu para sustentar esse crescimento inicial. A atuação de empresas e organismos ligados à modernização produtiva e energética, como a CEPISA²⁵ (Companhia Energética do Piauí) e a FRIPISA²⁶ (Frigorífico do Piauí S.A.), fortaleceu a base econômica e de serviços da cidade, tornando mais viável a ocupação de áreas além do centro tradicional, ainda que em ritmo moderado.

Do ponto de vista da forma urbana, a década de 1950 pode ser entendida como um momento de transição entre dois padrões de crescimento. Como observa Moreira (1972):

A planta da cidade de Teresina deixa perceber que o traçado original em xadrez constituiu a diretriz básica do crescimento e ocupação do Centro, contido entre o rio Parnaíba e o anel ferroviário; aí, as ruas são orientadas a grosso modo, de norte-sul e leste-oeste, com ruas estreitas e quadras geralmente de 100m. Esta orientação é percebida nos bairros de ocupação anterior a 1950. Naqueles de ocupação mais recente, a urbanização se faz de modo menos rígido, em torno de avenidas radiais, como no sudeste da cidade ocupado de 1950/60.²⁷

²⁵ Companhia Energética do Piauí S.A., empresa estatal criada para operar, expandir e modernizar o sistema de geração e distribuição de energia elétrica no estado do Piauí, desempenhando papel central na ampliação da infraestrutura urbana e no suporte ao crescimento econômico de Teresina a partir da segunda metade do século XX

²⁶ Frigorífico do Piauí S.A., empreendimento industrial vinculado ao processamento de produtos de origem animal, implantado como parte das iniciativas de modernização produtiva do estado, contribuindo para a dinamização econômica, a geração de empregos e o fortalecimento da base urbana e industrial de Teresina no período

²⁷ MOREIRA, A. A. N. et alii. A cidade de Teresina. Boletim Geográfico. Rio de Janeiro, IBGE, n.230, 1972.



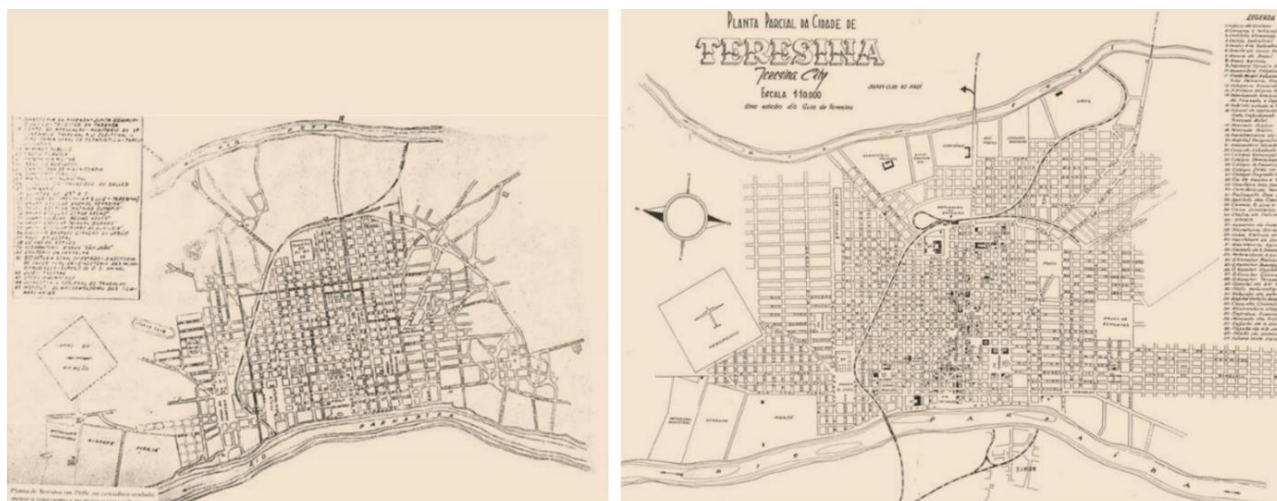


Figura 23 Mapas de Teresina nas décadas de 1930 e 1950, respectivamente.²⁸

Assim, no período anterior à construção da Ponte Juscelino Kubitschek, a ocupação do espaço urbano em Teresina caracterizou-se por um crescimento ainda fortemente condicionado pelos limites do núcleo original, pelos eixos viários já consolidados e por uma lógica de expansão gradual. Embora se observem, sobretudo a partir da década de 1950, sinais de flexibilização do traçado urbano, esses movimentos ocorreram de forma relativamente contida, sem romper de maneira decisiva com o padrão histórico de organização espacial da cidade.

Transformações urbanas no entorno do Rio Poti a partir de 1957

Ao contrário do rio Parnaíba, que sempre esteve no centro do desenvolvimento urbano de Teresina, o rio Poti passou a ganhar centralidade apenas na segunda metade do século XX. Até meados dos anos 1950, o Poti funcionava como um limite relativo à expansão urbana, pois as travessias existentes não garantiam integração viária permanente entre as duas margens, mantendo o crescimento concentrado no núcleo vinculado ao Parnaíba.

Essa condição começou a se alterar com a construção da Ponte Juscelino Kubitschek (Figura 24), em 1957, que estabeleceu uma conexão viária permanente entre as duas margens do rio e redefiniu os vetores de crescimento urbano de Teresina. A partir desse momento, a expansão deixou de se restringir quase exclusivamente ao

²⁸ SANTOS NETO (2002); GERÊNCIA DE GEOPROCESSAMENTO E PESQUISA – GGP (2021). Reprodução de Figueiredo e Paiva (2022).



núcleo histórico articulado ao Rio Parnaíba e passou a incorporar, de maneira mais sistemática, áreas situadas a leste do Rio Poti, superando um obstáculo natural que, até então, condicionava a expansão urbana da cidade



Figura 24 Construção da Ponte Juscelino Kubitschek.²⁹

Com a nova travessia, bairros como Fátima, Jóquei e São Cristóvão começaram a se estruturar ao longo dos eixos de circulação vinculados à ponte, configurando um processo inicial de urbanização da zona Leste. Esse movimento não representou apenas um deslocamento espacial da ocupação, mas também uma mudança na lógica de produção do espaço urbano, pois passou a articular investimentos públicos em infraestrutura viária com a valorização imobiliária de áreas antes pouco integradas à malha urbana consolidada (Figura 25).

Nesse contexto, segundo Façanha (1998), a zona Leste foi progressivamente definida como área prioritária de expansão urbana, em razão de sua topografia mais favorável, menor incidência de alagamentos e maior potencial de valorização do solo, fatores que redirecionaram parte dos investimentos públicos e privados para essa nova frente de crescimento.

²⁹ APIENG. *Memórias: Teresina – primeiras pontes sobre o Rio Poti*. 2024. Disponível em: <https://api-eng.com.br/memorias/teresina-primeiras-pontes-sobre-rio-poti/>. Acesso em: 10 janeiro 2026.



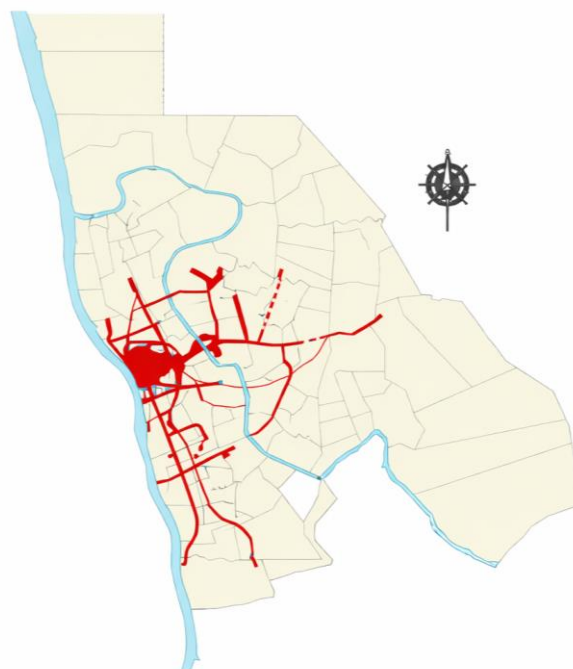


Figura 25 Mapa de expansão do sistema viário a partir da segunda metade do século XX.³⁰

A partir da década de 1960, a expansão para além do Poti passou a se articular de forma mais direta às políticas nacionais de habitação e urbanização implementadas pelo Banco Nacional da Habitação (BNH)³¹, criado em 1964. Em Teresina, essas diretrizes se materializaram por meio da atuação da COHAB-PI³², que passou a ser o principal agente promotor da produção de conjuntos habitacionais de interesse social no estado. Diferentemente de uma expansão espontânea e contínua do tecido urbano, esse processo foi fortemente induzido por grandes empreendimentos habitacionais localizados em áreas periféricas, sobretudo na zona Sul da cidade, consolidando um padrão de crescimento urbano induzido e espacialmente disperso.

O primeiro grande conjunto habitacional implantado em Teresina no âmbito dessas políticas foi o Conjunto Parque Piauí (Figura 26), em 1968, marco inicial da ação sistemática do BNH no município. Na década seguinte, esse modelo se ampliou com a construção de outros conjuntos, como Dirceu Arcoverde (1977) e Saci (1979),

³⁰ Fonte: CARDOSO, Luciene Brito, 2006. Adaptado pela autora.

³¹ Os conjuntos habitacionais populares foram produzidos no âmbito da política federal do Banco Nacional da Habitação (BNH), criado em 1964, que financiava moradias de interesse social por meio de companhias estaduais de habitação.

³² No Piauí, a COHAB-PI atuou como principal agente executor desses empreendimentos, implantando grandes conjuntos periféricos padronizados, que ampliaram a oferta de moradias, mas também reforçaram processos de periferização e segregação socioespacial.



que atenderam sobretudo a populações de baixa renda, mas foram implantados em áreas distantes do centro e com infraestrutura urbana ainda precária. Assim, embora essas iniciativas tenham ampliado a oferta formal de moradias, também contribuíram para a formação de periferias segregadas e funcionalmente dependentes do núcleo central.



Figura 26 Conjunto Habitacional Parque Piauí em 1968.³³

Paralelamente, os anos 1960 e 1970 foram marcados pela consolidação de Teresina como polo regional de serviços e administração pública, processo associado à instalação de empresas estatais e equipamentos estratégicos. A criação da CEPISA (1962)³⁴, da AGESPISA (1964)³⁵ e da Universidade Federal do Piauí (1970) fortaleceu o setor terciário e ampliou a capacidade da cidade de atrair população e investimentos, reforçando tanto a expansão para a zona Leste quanto a produção de novos bairros periféricos na zona Sul. Esse duplo movimento, valorização seletiva da Leste e

³³ Fonte: ACERVO COHAB-PI.

³⁴ A Companhia Energética do Piauí (CEPISA), criada em 1962, foi responsável pela expansão e regularização do sistema de geração e distribuição de energia elétrica no estado. Sua atuação foi fundamental para a modernização das atividades econômicas, a ampliação dos serviços urbanos e o adensamento de novas áreas residenciais e comerciais em Teresina.

³⁵ A Águas e Esgotos do Piauí S.A. (AGESPISA), instituída em 1964, assumiu a gestão dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado. Sua atuação foi estratégica para viabilizar novas frentes de urbanização em Teresina, embora a cobertura e a qualidade dos serviços tenham sido desiguais entre as diferentes zonas da cidade.



produção de habitação popular na Sul, passou a estruturar de forma duradoura a geografia social de Teresina.

A infraestrutura viária também passou por avanços consideráveis nesse período. A ampliação de avenidas estratégicas, como a Frei Serafim, Miguel Rosa e Barão de Gurguéia, permitiu uma melhor integração entre as diferentes zonas da cidade. A inauguração da então Ponte Presidente Médici (posteriormente denominada Tancredo Neves), em 1975, favoreceu as ligações entre as zonas Sul e Sudeste; em 1979, a Ponte Petrônio Portela (Ponte da Primavera) consolidou a conexão entre as zonas Norte e Leste; e, já nos anos seguintes, a Ponte Mariano Castelo Branco (1991) e a Ponte Wall Ferraz (1995) reforçaram as articulações entre as zonas Norte, Sul, Leste e Sudeste, integrando melhor o sistema viário interno e os acessos rodoviários.

A zona Norte passou por um processo distinto de incorporação à malha urbana. Até o final dos anos 1970, essa área era caracterizada por ocupação rarefeita, presença de atividades rurais e forte relação com o rio Parnaíba, funcionando mais como faixa de transição entre o centro urbano consolidado e o território rural do que como frente estruturada de expansão urbana (Façanha, 1998).

A partir da década de 1980, essa condição começou a se alterar gradativamente. A abertura de novas vias, a construção de pontes e a ampliação dos serviços urbanos passaram a integrar mais diretamente a zona Norte ao sistema viário e funcional de Teresina. Segundo Façanha (1998, p. 61), esse movimento esteve associado tanto a iniciativas do poder público quanto ao interesse de agentes privados, que passaram a enxergar a região como estratégica por sua proximidade com o centro expandido e pelos limites naturais impostos pelo rio Parnaíba.

Além disso, como destaca Abreu (2014, p. 121), a zona Norte passou a assumir papel relevante na dinâmica metropolitana de Teresina em razão de sua proximidade com Timon (MA) e da intensificação dos fluxos viários e comerciais entre as duas cidades. Essa posição favoreceu a requalificação de corredores urbanos, a instalação de equipamentos de maior escala e a articulação funcional entre os dois municípios, reforçando a importância dessa porção do território no sistema urbano regional.

Apesar dos avanços em infraestrutura e expansão urbana entre 1960 e 1980, o crescimento acelerado produziu efeitos contraditórios. A ausência de um planejamento urbano suficientemente eficaz contribuiu para a formação de vazios urbanos,



isto é, grandes áreas subutilizadas ou não edificadas dentro do perímetro urbano consolidado, associados a estratégias de retenção fundiária e à expectativa de valorização futura do solo (Melo, 2009).

Ao mesmo tempo, a expansão da mancha urbana não foi acompanhada na mesma velocidade pela oferta de serviços públicos essenciais. Problemas relacionados à mobilidade, ao saneamento básico e à distribuição desigual de equipamentos urbanos tornaram-se mais evidentes nas áreas periféricas, sobretudo na zona Sul e em partes da zona Norte, reforçando desigualdades socioespaciais já em formação.

Desse modo, o período compreendido entre as décadas de 1960 e 1980 foi decisivo para a configuração urbana de Teresina. A cidade ultrapassou definitivamente os limites do núcleo histórico vinculado ao rio Parnaíba e consolidou novas frentes de crescimento associadas ao rio Poti, à valorização da zona Leste e à implantação de grandes conjuntos habitacionais na zona Sul. Esse processo, contudo, ocorreu de forma desigual e seletiva, resultando em uma estrutura urbana fragmentada e marcada por contrastes territoriais persistentes.

Como observa Melo (2009, p. 104), os instrumentos de planejamento urbano implementados ao longo do século XX, embora orientados formalmente à ordenação do crescimento, acabaram por favorecer determinadas áreas em detrimento de outras, consolidando um modelo no qual a zona Leste foi priorizada por investimentos públicos e valorização imobiliária, enquanto a zona Sul concentrou a produção de habitação popular e a zona Norte permaneceu, por décadas, como área vulnerável em termos de infraestrutura e drenagem.

2.2 Contexto Histórico e Protagonista: Doutor Clidenor de Freitas Santos

O tratamento das pessoas com transtornos mentais em Teresina, ao longo da primeira metade do século XX, esteve diretamente associado à atuação de médicos que buscaram responder às limitações das estruturas existentes e às transformações em curso na psiquiatria brasileira. Nesse contexto, destaca-se a trajetória do médico Clidenor de Freitas Santos (Figura 27), nascido em Miguel Alves, Piauí, em 1913, personagem central no processo de institucionalização da psiquiatria no Piauí e figura decisiva para a criação do Sanatório Meduna.

Formado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Recife, em 1936, Clidenor de Freitas realizou, entre 1938 e 1939, período de aperfeiçoamento em psiquiatria



no Hospital do Juqueri, em São Paulo, então reconhecido como o principal centro de referência psiquiátrica do país. Essa experiência permitiu seu contato direto com práticas terapêuticas e modelos institucionais considerados modernos à época, marcando de forma decisiva sua formação profissional e suas concepções sobre o tratamento da saúde mental.

A vivência em São Paulo despertou em Clidenor não apenas o domínio técnico, mas uma inquietação sobre o papel do ambiente na cura. Oliveira (2011) destaca que o médico retornou ao Piauí movido por um "idealismo quixotesco", termo que remete à sua obra literária favorita e à sua luta para transformar a assistência psiquiátrica em um território até então marcado pelo abandono. Para ele, o tratamento de saúde mental não poderia ser dissociado de um espaço de dignidade e beleza.



Figura 27 Clidenor de Freitas Santos.³⁶

Ao retornar ao Piauí, Clidenor passou a atuar no atendimento psiquiátrico em Teresina, integrando o corpo médico do Asilo de Alienados, instituição então responsável pelo cuidado dos doentes mentais no estado, onde, a partir de 1940, assumiu a

³⁶ CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Biografia de Clidenor de Freitas Santos*. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/>. Acesso em: 27 jan. 2026.



direção da instituição, então denominado Hospital Psiquiátrico Areolino de Abreu, encontrando um cenário marcado por superlotação, precariedade das instalações e práticas de contenção ainda baseadas em métodos coercitivos. Essa realidade evidenciava os limites do modelo asilar vigente e reforçava a necessidade de mudanças na abordagem do tratamento psiquiátrico.

Durante sua gestão, Clidenor promoveu iniciativas voltadas à reformulação das práticas institucionais, alinhadas às transformações que vinham ocorrendo na psiquiatria brasileira nas décadas de 1930 e 1940. Inspirado pelas terapias biológicas então consideradas inovadoras, como a insulinoterapia e a eletroconvulsoterapia, passou a defender métodos que, naquele contexto, eram compreendidos como alternativas científicas às formas puramente repressivas de tratamento, ainda que hoje sejam objeto de críticas e revisões historiográficas.

Um dos episódios mais emblemáticos de sua atuação foi a retirada das correntes utilizadas para a contenção dos internos do antigo asilo. Em gesto de forte caráter simbólico, Clidenor expôs publicamente aproximadamente 1.540 quilos de ferro na Praça da Liberdade, evidenciando seu rompimento com práticas consideradas arcaicas e contribuindo para a construção de uma nova imagem pública da psiquiatria em Teresina, associada aos discursos de humanização e modernização científica (Franklin, 2017, p. 27).

O gesto de Clidenor ao expor os ferros da contenção era o anúncio da materialização do seu maior projeto. Segundo Oliveira (2011, p. 74):

O Meduna nasceu como um monumento à modernidade em Teresina. Não era apenas um hospital; era a prova de que o sertão piauiense poderia abrigar o que havia de mais avançado. Clidenor o ergueu às margens do Poti como quem constrói um oásis de razão, inspirando-se nas vanguardas europeias. Era o seu 'castelo de sonhos' contra a barbárie do isolamento.

Diante das limitações estruturais da instituição que dirigia e da impossibilidade de implementar plenamente suas propostas naquele espaço, Clidenor passou a conceber a criação de uma nova instituição psiquiátrica. Esse projeto resultou na fundação do Sanatório Meduna, inaugurado em 1954, concebido como um estabelecimento especializado, capaz de materializar, em termos institucionais, os princípios médicos e terapêuticos que defendia. O nome Meduna foi escolhido em homenagem ao médico



húngaro Ladislau von Meduna, precursor do uso da convulsoterapia induzida, cujos estudos influenciaram diretamente os primeiros tratamentos adotados no sanatório, como a insulinoaterapia e a eletroconvulsoterapia (Franklin, 2017, p. 48).

Essa homenagem a von Meduna reforçava o desejo do protagonista de sintonizar a capital piauiense com a vanguarda científica internacional. Oliveira (2011) enfatiza que, ao batizar o sanatório, Clidenor estabelecia um vínculo simbólico entre Teresina e os grandes centros de pesquisa mundiais, rompendo o isolamento geográfico através do conhecimento.

O Sanatório Meduna consolidou-se, ao longo de seu funcionamento, como referência no atendimento psiquiátrico para a região Norte e Nordeste do país, reforçando o protagonismo de Clidenor de Freitas Santos na história da saúde mental no Piauí. Sua atuação, no entanto, revela as ambiguidades próprias do processo de modernização da psiquiatria no Brasil, no qual discursos de humanização coexistiram com a permanência do modelo manicomial, ainda que reformulado.



Figura 28 Fachada do antigo Sanatório Meduna.³⁷

Além de sua trajetória médica, Clidenor também teve participação na vida pública, exercendo mandato como deputado federal pelo Piauí entre 1959 e 1963. Após

³⁷ Fonte: FGV, foto datada em 1968.



o golpe civil-militar de 1964, teve seus direitos políticos cassados, resultando em período de exílio em países da América do Sul, como Chile, Peru e Uruguai. Posteriormente, retornou a Teresina, onde retomou suas atividades profissionais e intelectuais.

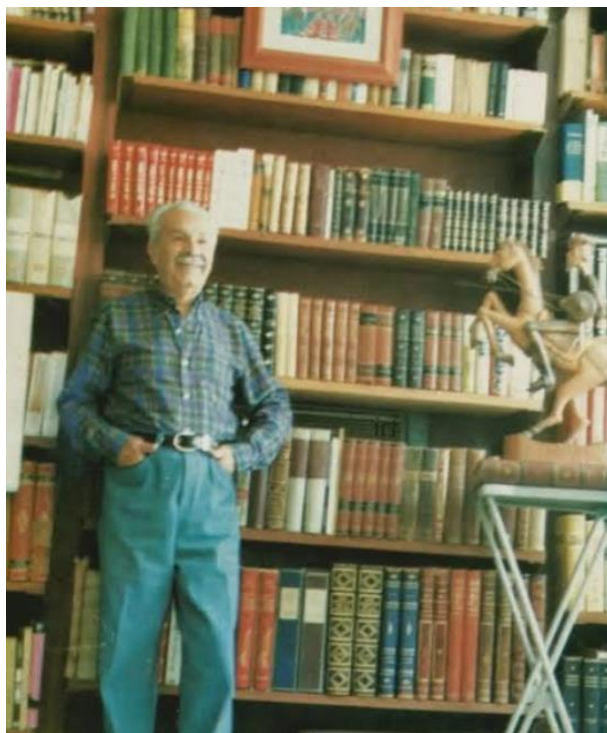


Figura 29 Doutor Clidenor de Freitas Santos em sua biblioteca pessoal.³⁸

Além de sua atuação médica e política, Clidenor é lembrado, em relatos locais, por seu apreço pela leitura e pelo contato constante com livros, sendo *Dom Quixote*, de Miguel de Cervantes, frequentemente citado como uma de suas obras favoritas (Figura 04). Compreender a trajetória de Clidenor de Freitas Santos é fundamental para a análise do Sanatório Meduna, uma vez que a história e a arquitetura da instituição, abordadas no item seguinte, constituem a materialização espacial de um projeto médico, institucional e simbólico conduzido por seu fundador.

³⁸ Fonte: Colunista Nilo Araújo, 2025.



2.3 Sanatório Meduna: História e Arquitetura

Inauguração e Auge (1954-1990)

Inaugurado em 1954, o Sanatório Meduna representou um marco na história da assistência psiquiátrica no Piauí, ao materializar, em forma institucional e arquitetônica, o projeto médico defendido por Clidenor de Freitas Santos. Concebido como um hospital psiquiátrico moderno para os padrões da época, o Meduna distinguiu-se tanto por sua proposta terapêutica quanto por sua organização espacial, assumindo papel central no atendimento de pacientes provenientes não apenas de Teresina, mas também de outras regiões do estado e do Norte e Nordeste do país.

Implantado às margens do rio Poti, em uma área então afastada do núcleo urbano consolidado, o sanatório ocupava um terreno de aproximadamente 3.356 m², condição que possibilitou a adoção de um conjunto arquitetônico horizontal e pavilho-nar. Essa localização atendia a uma lógica recorrente na implantação de instituições psiquiátricas ao longo do século XX, que privilegiava áreas amplas, com menor densidade urbana e maior contato com a paisagem natural, compreendida, naquele contexto, como elemento favorável ao tratamento e à recuperação dos pacientes. (Figura 30)



Figura 30 Sanatório Meduna na década de 1950.³⁹

³⁹ Acervo histórico do Sanatório Meduna. Autor desconhecido.



O conjunto arquitetônico do Sanatório Meduna era composto por oito pavilhões interligados por corredores cobertos, organizados em torno de dois pátios centrais⁴⁰. Essa configuração permitia uma circulação contínua e controlada entre os diferentes setores, ao mesmo tempo em que favorecia a entrada de luz natural e a ventilação dos ambientes. Diferentemente dos modelos hospitalares mais antigos, marcados por espaços fechados e forte sensação de confinamento, o Meduna apresentava uma organização espacial que buscava atenuar o caráter opressivo típico dos hospitais psiquiátricos, reforçando o discurso de tratamento humanizado defendido por seu fundador.

Cada pavilhão possuía funções específicas relacionadas aos diferentes tipos de internação e tratamento, evidenciando uma setorização clara entre áreas de acomodação, circulação, convivência e serviços. O edifício principal, com dois pavimentos, concentrava parte significativa das atividades administrativas e de internação, dispondo de cerca de 120 leitos. A hierarquização dos espaços, aliada à adoção de pátios internos, permitia o convívio entre os pacientes sob supervisão, conciliando controle institucional e maior liberdade de circulação, aspecto considerado inovador no contexto regional.

Com elementos associados ao ecletismo, incorporando traços neoclássicos e neocoloniais, o edifício dialogava com a arquitetura institucional presente em outras áreas de Teresina no mesmo período. Essa escolha contribuía para conferir monumentalidade e visibilidade ao conjunto, reforçando sua imagem como símbolo de progresso e modernização da saúde mental no estado. Tal percepção foi amplamente difundida pela imprensa local, que chegou a se referir ao sanatório como o “Taj Mahal Piauiense”, em alusão à grandiosidade arquitetônica do edifício e ao impacto visual que exercia na paisagem urbana (Franklin, 2017, p. 69).

⁴⁰ Não foram localizados registros completos das plantas arquitetônicas originais do Sanatório Meduna referentes ao período de sua inauguração. A compreensão de sua configuração espacial baseia-se, portanto, em registros fotográficos, descrições documentais e na análise do conjunto, permitindo identificar sua organização pavilhonar, os sistemas de circulação e a relação entre espaço construído e práticas terapêuticas adotadas à época.





Figura 31 Recorte da notícia do Jornal O DIA.⁴¹

Segundo Moreira (2016), o projeto arquitetônico do Sanatório Meduna foi idealizado pelo engenheiro Cícero Ferraz de Souza Martins, um dos principais nomes da arquitetura e da engenharia em Teresina durante a primeira metade do século XX. Formado em engenharia civil, Cícero Ferraz atuou intensamente no cenário local entre as décadas de 1930 e 1950, sendo responsável por diversas obras residenciais e institucionais de destaque.

A autora ressalta que sua produção arquitetônica se insere no contexto do ecletismo presente na cidade, incorporando traços neocoloniais, bem como a preocupação em adaptar os edifícios ao clima local e às necessidades sociais. No caso do Sanatório Meduna, essa linguagem formal contribuiu para conferir monumentalidade ao conjunto, reforçando sua visibilidade e sua inserção simbólica na paisagem urbana.

Declínio e Encerramento (1990-2010)

Ao longo de seus 56 anos de funcionamento, de 1954 a 2010, o Sanatório Meduna teve um papel fundamental no cuidado de pacientes psiquiátricos, se destacando como um dos principais centros de tratamento da região. No entanto, como muitas instituições psiquiátricas, o sanatório enfrentou sérias dificuldades ao longo das últimas décadas de sua operação. A partir dos anos 1990, o sanatório começou a enfrentar problemas financeiros e o desgaste da infraestrutura que comprometiam progressivamente a qualidade do atendimento. A falta de recursos para a manutenção

⁴¹ *Idem.*



e atualização dos serviços e instalações prejudicou a capacidade da instituição de atender de forma eficiente e adequada os pacientes.

Esse processo de fragilização institucional não pode ser compreendido de forma isolada, uma vez que se insere em um contexto mais amplo de transformações nas políticas de saúde mental no Brasil. A partir das décadas de 1980 e 1990, o avanço das diretrizes da reforma psiquiátrica passou a questionar o modelo manicomial tradicional, baseado na internação prolongada em grandes hospitais especializados. Nesse cenário, instituições como o Sanatório Meduna, estruturadas segundo uma lógica hospitalar consolidada ao longo do século XX, passaram a perder centralidade no sistema de atenção à saúde mental, enfrentando dificuldades de adaptação às novas diretrizes assistenciais e às exigências técnicas e sanitárias emergentes.

Em maio de 2010, diante dessa crise, o Sanatório Meduna anunciou a suspensão dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS) devido a sérios problemas administrativos e financeiros. O impacto dessa decisão foi imediato, afetando diretamente o atendimento à população que dependia do serviço público de saúde. A partir de 2011, a situação se agravou com a desativação da instituição. A estrutura física do sanatório foi então vendida, e grande parte do edifício foi demolida para dar lugar à construção do Shopping Rio Poty, um projeto comercial que foi inaugurado em 2015 (Figura 32, 33 e 34).





Figura 32 Foto aérea da edificação antes de sua demolição.⁴²



Figura 33 Foto aérea de parte da edificação depois de sua demolição.⁴³

⁴² Fonte: Google Earth setembro de 2011.

⁴³ Fonte: Google Earth outubro de 2012.





Figura 34 Foto aérea de parte da edificação depois de sua demolição.⁴⁴

O fechamento do Sanatório Meduna marcou o fim de um importante ciclo na história da saúde mental no Piauí, com a extinção de uma instituição que, por décadas, foi pioneira no tratamento dos pacientes psiquiátricos. Ao mesmo tempo em que sua desativação marca uma ruptura, ela também convida à reflexão sobre a preservação da memória e sobre como a cidade lida com espaços que foram, por tanto tempo, social e simbolicamente relevantes.

Para além das questões diretamente relacionadas à assistência em saúde, o encerramento do Sanatório Meduna deve ser analisado também considerando as transformações urbanas ocorridas em Teresina nas últimas décadas. A valorização imobiliária da área onde o sanatório estava implantado, associada à crescente pressão por novos empreendimentos comerciais, contribuiu para redefinir o destino do conjunto edificado. Nesse sentido, a desativação da instituição e a posterior venda do terreno revelam a fragilidade dos mecanismos de proteção do patrimônio edificado vinculado à história da saúde e da assistência psiquiátrica, evidenciando a predominância de interesses econômicos sobre a preservação de espaços social e simbolicamente relevantes.

⁴⁴ Google Earth outubro de 2024.



CAPÍTULO 3: PATRIMÔNIO E MEMÓRIA

3.1 Políticas de preservação do patrimônio de Teresina

A preservação do patrimônio cultural em Teresina envolve ações das esferas municipal, estadual e federal, cada uma com competências, instrumentos legais e formas de atuação distintas. Ao longo do tempo, essas instâncias têm buscado proteger elementos da cidade dotados de valor histórico, arquitetônico e simbólico. Entretanto, a literatura aponta que esse processo tem ocorrido de maneira fragmentada, com ações pontuais e dificuldades de articulação institucional, o que compromete a efetividade das políticas de preservação e contribui para a perda de referências materiais da memória urbana.

Nesse contexto, a paisagem urbana de Teresina revela um processo marcado por tensões entre preservação e transformação, no qual a memória coletiva é frequentemente ameaçada por intervenções associadas à expansão urbana, à valorização imobiliária e à ausência de políticas integradas de salvaguarda. Como observa Moura (2021), a modernização da cidade ocorreu de forma seletiva, privilegiando determinados setores e relegando outros à descaracterização ou ao esquecimento.

Em nível federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) possui atuação histórica no Piauí desde os primeiros anos de sua criação, quando ainda era denominado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).

Em Teresina, uma das primeiras iniciativas de proteção ocorreu em 1938, com o tombamento das portas da Igreja de São Benedito⁴⁵ (Figura 35), reconhecidas por seu valor artístico e histórico, sem que a edificação como um todo fosse incluída no processo de salvaguarda. Essa forma de proteção evidencia uma compreensão inicial do patrimônio centrada em elementos isolados, e não na leitura do conjunto urbano ou da paisagem cultural. (Cardoso, 2006)

⁴⁵ O tombamento federal das portas da Igreja de São Benedito, em Teresina, foi realizado em 1938 pelo então SPHAN (Processo nº 184-T-1938), incidindo sobre cinco das sete portas de madeira entalhadas pelo artista piauiense Sebastião Mendes. A proteção não abrangeu a edificação como um todo. As portas passaram por restauração recente, concluída em 2022.





Figura 35 Portas da Igreja São Benedito em Teresina.⁴⁶

Ainda no âmbito federal, destacam-se outros bens tombados no estado, como o Cemitério do Batalhão⁴⁷ (Figura 36), em Campo Maior, e a Ponte Grande, em Oeiras. A Superintendência Regional do IPHAN no Piauí foi formalmente criada apenas em 2013, o que contribuiu para ampliar a capacidade técnica e administrativa do órgão no estado. Antes disso, a atuação era realizada de forma indireta, vinculada a outras unidades regionais, o que limitava a presença institucional contínua em Teresina. (Santos, 2019)



Figura 36 Monumento aos Heróis do Jenipapo, localizado em Campo Maior.⁴⁸

⁴⁶ Fonte: Acervo Digital do Iphan.

⁴⁷ O Monumento aos Heróis do Jenipapo, localizado em Campo Maior, presta homenagem às pessoas que morreram em combate durante a Batalha do Jenipapo, ocorrida em 13 de março de 1823, no decorrer do processo de independência do Brasil.

⁴⁸ PIAUÍ. Governo do Piauí comemora 202 anos da Batalha do Jenipapo nesta quarta (12), em Campo Maior. Teresina: Governo do Estado do Piauí, 2025. Disponível em: <https://www.pi.gov.br/governo-do-piaui-come-mora-202-anos-da-batalha-do-jenipapo-nesta-quarta-12-em-campo-maior/>. Acesso em: 6 fev. 2026.



Entre os bens tombados mais recentemente pelo IPHAN no Piauí estão a Floresta Fóssil do rio Poti e a Ponte Metálica João Luís Ferreira, ambos tombados em 2008. Em 2024, foi aprovado o tombamento da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, bem como o registro da Arte Santeira em madeira do Piauí como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

No mesmo período, foram retomados estudos para o reconhecimento do centro histórico de Teresina como área de interesse para preservação, com destaque para as praças Rio Branco, Pedro II e Marechal Deodoro, espaços que concentram valores históricos, simbólicos e paisagísticos fundamentais para a compreensão da formação urbana da cidade. (Cardoso, 2006)

No âmbito estadual, a política de preservação é conduzida pela Secretaria de Estado da Cultura do Piauí (SECULT). Em 2021, o Sanatório Meduna recebeu reconhecimento oficial como patrimônio estadual por meio do Decreto nº 20.201, de 5 de novembro de 2021, que declarou o edifício como Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Estado do Piauí. Embora esse ato represente um avanço no reconhecimento de bens vinculados à arquitetura institucional e à história da saúde, seu caráter tardio evidencia limites recorrentes das políticas de preservação, que frequentemente reconhecem o valor patrimonial apenas quando o bem já se encontra ameaçado ou parcialmente descaracterizado. (Melo, 2011)

No nível municipal, a política patrimonial é conduzida principalmente pela Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC) e pela Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPPLAN). A FMC atua no tombamento e na gestão de bens culturais em âmbito local, enquanto a SEMPLAN é responsável pelo planejamento urbano e pela delimitação das Zonas de Preservação (ZP). Em 2009, o Decreto Municipal nº 9.619 passou a exigir a anuência conjunta da FMC, da SECULT e do IPHAN para intervenções nas áreas centrais da cidade, instituindo formalmente um espaço de diálogo entre os diferentes níveis de governo. Apesar desse avanço normativo, estudos apontam que a aplicação prática desses instrumentos tem sido limitada, resultando em recorrentes processos de descaracterização do patrimônio edificado, sobretudo no centro histórico de Teresina. (Bessa, 2022)

Desse modo, a política de preservação do patrimônio em Teresina revela um percurso marcado por avanços institucionais, mas também por lacunas significativas, especialmente no que se refere à atuação preventiva, à leitura integrada da paisagem



urbana e à valorização de bens associados à memória social recente. Essa realidade ajuda a compreender os impasses enfrentados no reconhecimento e na preservação de espaços como o Sanatório Meduna.

3.2 Inserção do Meduna como patrimônio

O antigo Sanatório Meduna está situado na zona norte da cidade de Teresina, capital do Piauí, no bairro Porequanto. O terreno está localizado às margens do rio Poti, na Avenida Marechal Castelo Branco, uma das principais vias arteriais do município, caracterizada pelo intenso fluxo de veículos e controlada por semáforos. Essa avenida desempenha papel fundamental no sistema viário local, conectando lotes vizinhos e diversas ruas secundárias. Observa-se claramente o crescimento urbano na região, especialmente com a construção do Shopping Rio Poty, que ocupa grande parte do lote vizinho, refletindo a dinâmica de expansão e transformação da paisagem urbana ao redor do antigo sanatório (Figura 37).



Figura 37 Vista aérea do bairro Porequanto.⁴⁹

Nas proximidades do bairro, destacam-se espaços públicos relevantes, como a Praça do Marquês, uma das mais antigas da cidade, que concentra atividades comerciais e culturais, e a Praça da Bandeira, situada no centro da cidade, importante

⁴⁹ *Idem.*



ponto de referência cívica e histórica. Também compõem o entorno importantes instituições públicas e marcos arquitetônicos, como o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a Assembleia Legislativa, o Centro de Convenções de Teresina, a antiga sede da AGESPISA.

Outro elemento de destaque na paisagem urbana próxima ao Meduna é a antiga Estação Ferroviária de Teresina, atual sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A estação, além de representar um marco da história da infraestrutura e mobilidade da capital, reforça o caráter patrimonial do entorno ao agregar valor simbólico e institucional à região.

A presença desses espaços evidencia que, embora concebido originalmente como um espaço isolado, voltado ao tratamento de pacientes em conformidade com as diretrizes sanitárias da época, o Sanatório Meduna integrava uma área privilegiada, originalmente escolhida por suas qualidades ambientais, como ventilação, luminosidade e afastamento do centro urbano, mas que, com o passar das décadas, passou a fazer parte de uma região valorizada e densamente urbanizada.

A edificação do antigo Sanatório Meduna é atribuída ao engenheiro Cícero Ferraz de Souza Martins, profissional que atuou de forma significativa na transformação da paisagem urbana de Teresina entre as décadas de 1930 e 1950. Conforme aponta Moreira (2016), Cícero Ferraz foi um dos principais responsáveis por difundir o estilo neocolonial na cidade, sendo autor de diversas edificações públicas e residenciais que aliaram repertórios formais do Ecletismo a soluções construtivas adaptadas ao clima e à cultura local. Sua atuação esteve diretamente associada à busca por uma arquitetura que, além de funcional, expressasse prestígio e modernidade, sem romper com os códigos estéticos tradicionais valorizados na época.

Entre as obras referenciadas por Moreira (2016), destaca-se a chamada “Casa cor de rosa” (Figura 38), projetada por Cícero para sua própria família na Avenida Frei Serafim. Tal residência apresenta elementos arquitetônicos semelhantes aos encontrados no Sanatório Meduna, como o uso de platibandas recortadas, telhados em telha cerâmica à vista, esquadrias em madeira com bandeiras envidraçadas e detalhes decorativos em alvenaria moldada. Esses recursos apontam para uma linguagem visual comum que se repetia em projetos de caráter institucional e residencial, vinculando o Meduna a uma produção arquitetônica regional marcada por uma apropriação cuidadosa do ecletismo, com predominância do neocolonial.





Figura 38 “Casa cor-de-rosa”, residência construída pelo engenheiro Cícero Ferraz de Souza Martins para sua família.⁵⁰

A imagem histórica do conjunto (Figura 39), registrada em recorte de jornal, em 1954, permite compreender a configuração original do Sanatório Meduna, evidenciando uma implantação pavilhonar. Observa-se a presença de blocos edificadas independentes, distribuídos no terreno e interligados por galerias cobertas de circulação, formando uma estrutura articulada que possibilitava a separação funcional entre os diferentes setores.



Figura 39 Recorte da notícia do Jornal O DIA com imagem da parte de trás do Sanatório Meduna, em 1954.⁵¹

⁵⁰ MOREIRA, Amanda Cavalcante. *Teresina e as moradias da região central da cidade (1852–1952)*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.

⁵¹ Fonte: Jornal O DIA, abril de 1954.



Atualmente, após demolições e perdas ao longo do tempo, permanece apenas a porção frontal do complexo, composta pelo bloco central e dois volumes laterais conectados por corredores, configuração representada na planta apresentada a seguir, à qual se somam duas estruturas anexas incorporadas posteriormente durante as obras do shopping, destinadas a funções de apoio, além da igreja implantada em uma das laterais do conjunto (Figura 40 e 41).

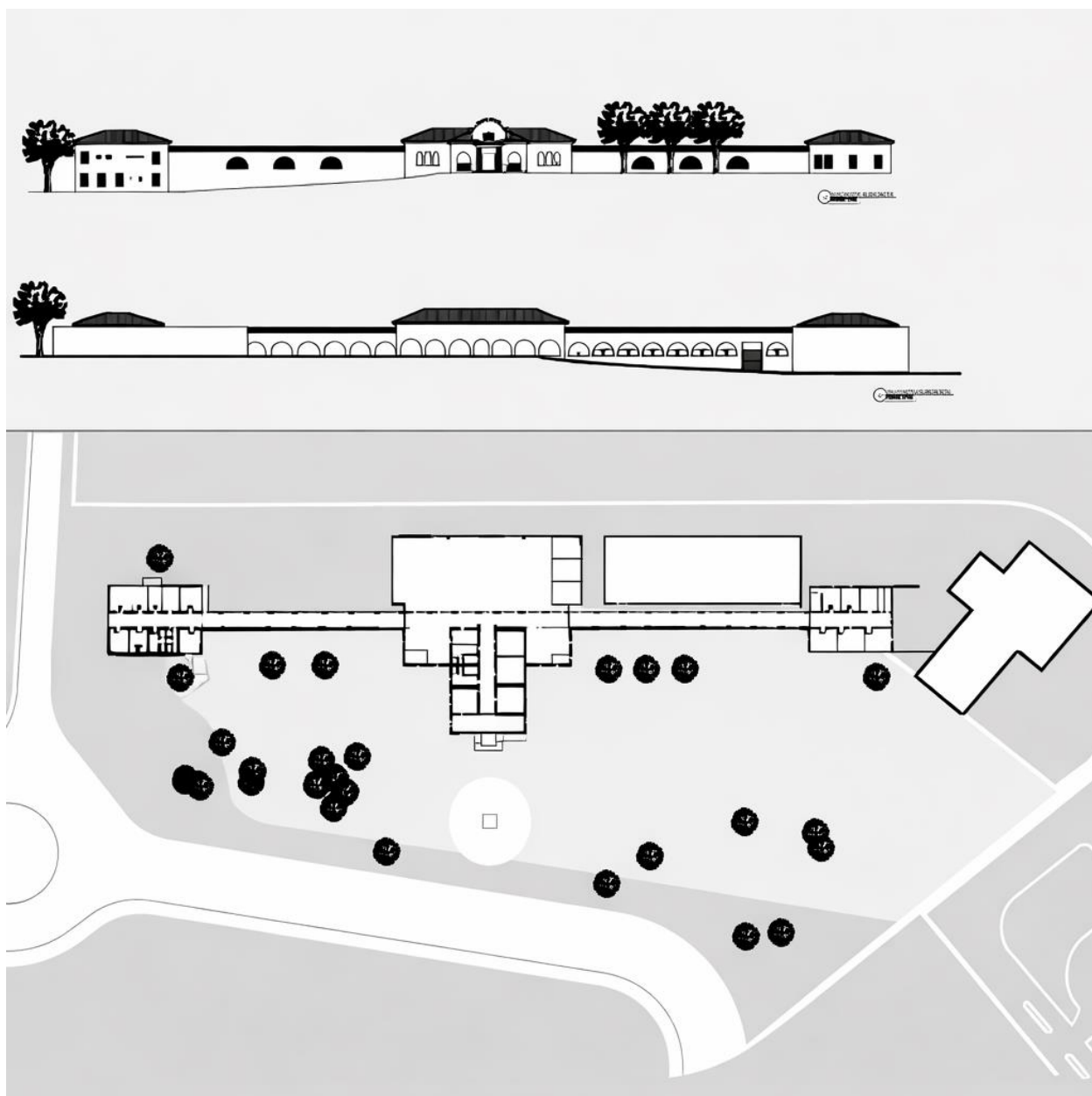


Figura 40 Representação da planta baixa e fachadas da estrutura existente após a demolição.⁵²

⁵² Elaborado pela autora, 2026.





Figura 41 Sanatório Meduna em 2005, em destaque os blocos que permanecem após a demolição.⁵³

O partido arquitetônico do antigo Sanatório Meduna revela uma organização setorizada, distribuída em blocos independentes interligados por um eixo de circulação longitudinal, o que permitia o funcionamento de diferentes atividades de forma autônoma e racional. Essa fragmentação volumétrica, combinada à integração com áreas abertas e jardins, aponta para uma concepção arquitetônica voltada ao conforto ambiental e à recuperação dos pacientes por meio do contato com o espaço externo. Trata-se de uma estratégia recorrente nos projetos de sanatórios construídos no Brasil entre as décadas de 1930 e 1960, alinhada às diretrizes sanitárias da época.

A fachada (Figura 42 e 43) preservada apresenta ritmo e simetria compositiva, marcada por arcos plenos preenchidos com cobogós cerâmicos, cimalhas moldadas em alvenaria e frontão recortado, além do uso de telhas aparentes como elementos decorativos. A entrada principal, em posição levemente avançada em relação ao corpo do edifício, é valorizada por uma escadaria ladeada por pilares e guarda-corpos também em cobogós, acentuando o caráter institucional da construção.

⁵³ Fonte: CARVALHO, Thais Oliveira, 2018.





Figura 42 Fachada do antigo Sanatório Meduna em 2018..⁵⁴



Figura 43 Fachada do antigo Sanatório Meduna em 2018..⁵⁵

A implantação do edifício sobre terreno de relevo acidentado exigiu soluções estruturais específicas, como a execução de alicerces revestidos com tijoleira e adobe (Figura 44), com espessuras variáveis conforme a carga que suportam. As paredes, internas e externas, são compostas por alvenaria de tijolos cerâmicos perfurados, com espessura média de 25 cm.

⁵⁴ Fonte: Acervo Pessoal da autora, 2018.

⁵⁵ *Idem.*





Figura 44 Lateral do Sanatório Meduna e seu acabamento construtivo.⁵⁶

As esquadrias adotam formas retangulares, com bandeiras envidraçadas e venezianas de madeira, evidenciando a preocupação com ventilação e iluminação naturais. O acesso principal ao edifício se dá por um corredor longitudinal, no qual se localizam duas portas expressivas: uma com almofadas entalhadas, balaústres e báculo envidraçada; a outra, em arco pleno, também em madeira almofadada (Figura 45).



Figura 45 Portas do Sanatório Meduna.⁵⁷

⁵⁶ Fonte: Acervo Pessoal da autora, 2018.

⁵⁷ *Idem.*



A cobertura é executada com telhas cerâmicas do tipo capa e canal, e o telhado do corredor central apresenta duas águas sustentadas por tesouras simples de madeira. O forro de madeira em alguns ambientes é do tipo “saia-e-camisa”, com tábuas encaixadas e trechos decorativos vazados, conferindo leveza ao ambiente interno.

Quanto aos acabamentos, observa-se a presença de diferentes tipos de pisos que variam conforme a função dos espaços. No hall principal, o revestimento é composto por pastilhas hidráulicas hexagonais; nos ambientes internos e no corredor central, predominam tacos de madeira clara e escura, dispostos em espinha de peixe. Em áreas que sofreram intervenções posteriores, foram identificados pisos em cerâmica branca.



Figura 46 Detalhe do telhado e forro.⁵⁸

O corredor de ligação entre os blocos apresenta revestimento com pastilhas octogonais combinadas com peças losangulares, enquanto os pavilhões laterais mantêm pisos em ladrilho hidráulico com padrões geométricos e ornamentais variados. A diversidade de acabamentos revela o cuidado técnico e estético dedicado à edificação, mesmo tratando-se de uma instituição de saúde, refletindo os valores de dignidade, ordem e permanência atribuídos a esse tipo de arquitetura no período em que foi concebida.

⁵⁸ Fonte: Acervo Pessoal da autora, 2018.



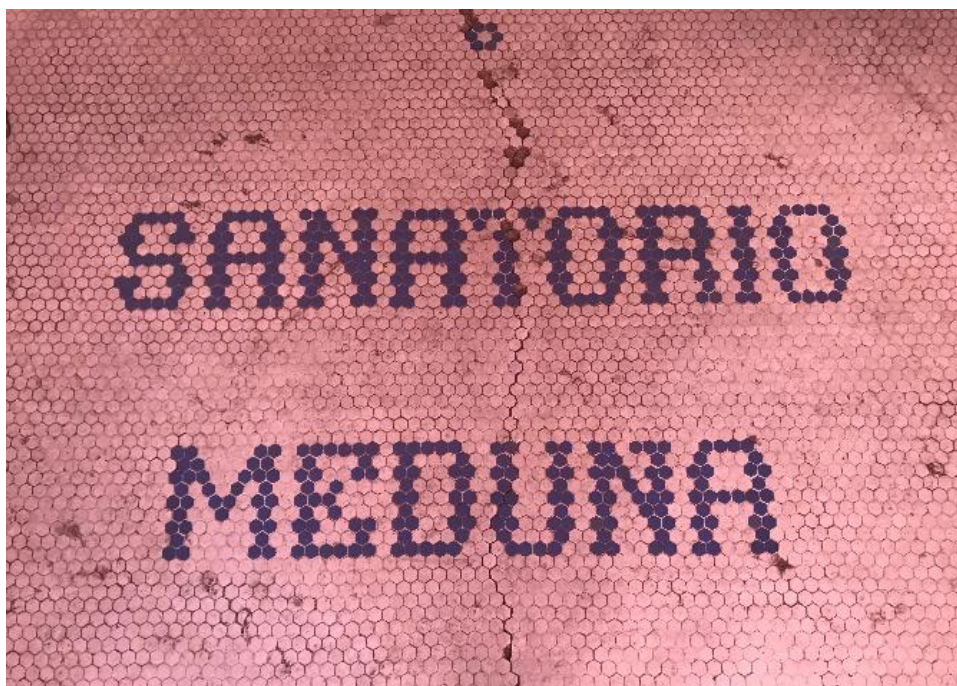


Figura 47 Ladrilho do Hall de entrada.⁵⁹

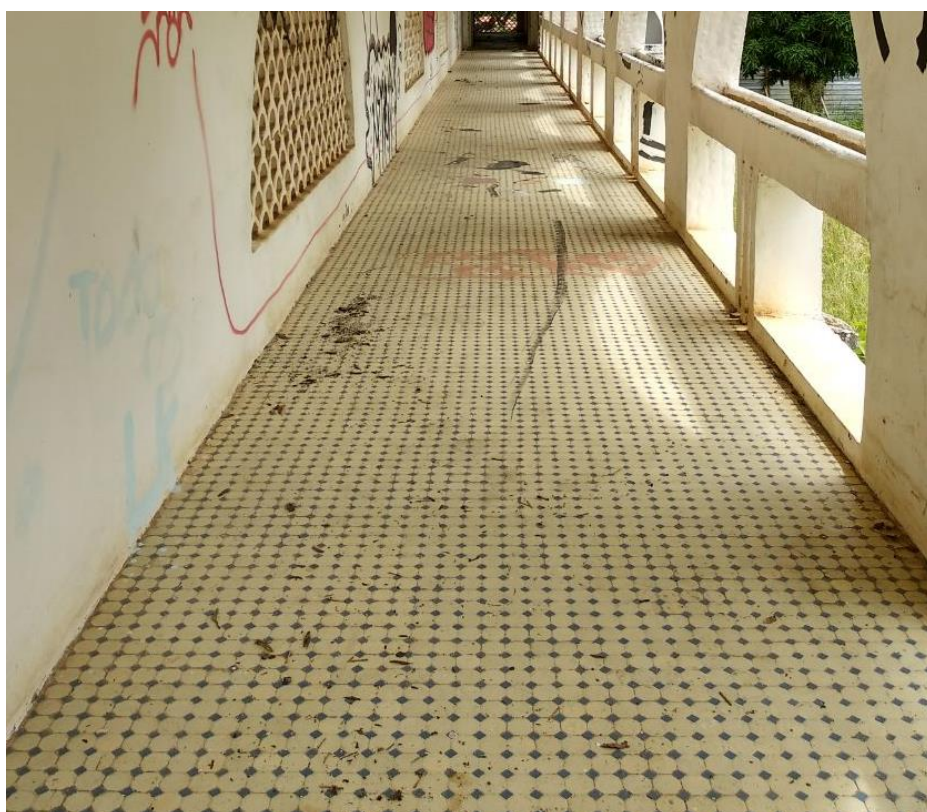


Figura 48 Piso do corredor central.⁶⁰

⁵⁹ Fonte: Acervo Pessoal da autora, 2018.

⁶⁰ *Idem.*





Figura 49 Corredores que interligavam os pavilhões (antes da demolição).⁶¹

A igreja localizada na lateral do antigo Sanatório Meduna foi construída na década de 1960. Sua linguagem arquitetônica apresenta elementos associados ao Art Déco tardio, perceptíveis no rigor geométrico da composição, na predominância de linhas verticais e na intenção de conferir maior esbeltez visual ao volume.



Figura 50 Parte Externa e Interna da Igreja, em 2018.⁶²

⁶¹ Fonte: Acervo da Arquiteta Carolina Martins, 2012.

⁶² Fonte: Acervo Pessoal da autora, 2018.



A fachada é marcada por porta em arco pleno e venezianas em madeira, enquanto o interior preserva características originais como piso em ladrilho hidráulico, forro em gesso ornamentado e aberturas circulares laterais. Intervenções realizadas no início da década de 2020 buscaram conservar esses elementos, incluindo recuperação do telhado, esquadrias e instalações, além da adequação de espaços de apoio ao uso contemporâneo.



Figura 51 Fachada da Igreja, após a reforma, em 2021.⁶³



Figura 52 Interior da Igreja, após a reforma, em 2021.⁶⁴

⁶³ G1 Piauí. Disponível em: <https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2021/01/28/capela-do-antigo-sanatorio-meduna-em-teresina-comeca-a-ser-reformada-e-ganha-novo-nome.shtml>. Acesso em: 12 fev. 2026.

⁶⁴ *Idem.*



Após o edifício enfrentar um longo processo de degradação e descaracterização nas últimas décadas, o conjunto preservado foi incorporado à gestão da Prefeitura Municipal de Teresina, como uma tentativa de preservar o que restava desse patrimônio.

Em 2021, diante do iminente risco de demolição da estrutura remanescente, impulsionado por interesses privados, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí (CAU-PI) se mobilizaram para impedir a destruição do edifício. A ação conjunta dessas instituições levou à formalização de um pedido de tombamento junto ao Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), reforçando a urgência da proteção legal.

Como resultado desse esforço colaborativo, em novembro de 2021 foi publicado o Decreto Estadual nº 20.201, que declarou o Sanatório Meduna como Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Estado do Piauí, consolidando sua inserção formal nas políticas de preservação estadual e garantindo sua proteção contra novas intervenções destrutivas.

3.3 Venda do terreno, Criação do Rio Poty Shopping e Construções em andamento no terreno do Antigo Sanatório Meduna

Nas últimas décadas do século XX, o Sanatório Meduna passou por um processo de desativação e abandono, reflexo das mudanças nas políticas públicas voltadas à saúde mental. Essa desocupação progressiva resultou na venda de parte significativa do terreno original do sanatório para o setor privado, o que marcou o início de uma transformação profunda no uso desse espaço urbano. A comercialização da área abriu caminho para empreendimentos imobiliários e comerciais, alterando radicalmente a paisagem do bairro Porenquanto, onde o sanatório está localizado.

Em 2007, o terreno cedido para o setor privado foi utilizado para a implantação do Rio Poty Shopping, um dos maiores centros comerciais de Teresina. A instalação desse empreendimento significou uma mudança de paradigma na ocupação da região, que deixou de abrigar uma instituição de saúde para se tornar um polo de consumo e serviços. A construção do shopping gerou impactos significativos no entorno, tanto em termos urbanos quanto sociais, provocando debates sobre a preservação do



patrimônio cultural e os interesses econômicos relacionados à expansão imobiliária na capital.



Figura 53 Shopping Rio Poty e Torres Empresariais.⁶⁵

A área, que originalmente abrigava o hospital psiquiátrico, foi gradualmente incorporada a projetos imobiliários e comerciais que marcam o desenvolvimento da cidade. A concepção do complexo Rio Poty Shopping, idealizado pelo Grupo Sá Cavalcante, iniciou-se em 2009 com a proposta de criar um espaço multiuso que integrasse comércio, lazer, cultura e moradia (Figura 54), utilizando uma área às margens do Rio Poty, onde funcionava o sanatório desativado em 2010.



Figura 54 Projeto Reserva Rio Poty em 2012.⁶⁶

⁶⁵ Autor Desconhecido. Disponível em: <https://www.shoppingsacavalcante.com.br/>

⁶⁶ Vídeo de divulgação de empreendimento imobiliário. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BU3KXQW3R0o>. Acesso em: 25 fev. 2025.



O lançamento oficial do Rio Poty Shopping ocorreu em 2012, com previsão inicial de inauguração para 2013. Após alguns adiamentos, o empreendimento foi inaugurado em setembro de 2015, consolidando-se como o maior centro comercial do Piauí, com mais de 47 mil metros quadrados de área bruta locável, mais de 200 lojas e um complexo de cinema moderno. O projeto também incluiu a instalação de torres empresariais, ampliando o uso da área para fins corporativos.

Em 2023, o Grupo Sá Cavalcante anunciou a construção do condomínio de luxo La Reserve, edifício 25 andares, voltado para um público de alto poder aquisitivo, dentro do mesmo terreno onde está o Shopping Rio Poty. Essa construção revela como os interesses do mercado imobiliário seguem se sobrepondo à preservação da memória da cidade. Mesmo com o Meduna tombado como patrimônio histórico, ele acaba ofuscado por um empreendimento que valoriza apenas o lucro e a exclusividade, sem considerar o contexto histórico e cultural do local onde está sendo erguido.



Figura 55 Vista aérea do La Reserve ao lado do Shopping Rio Poty.⁶⁷

⁶⁷ G1 Piauí. **La Reserve dá a largada para imóveis de luxo com padrão Dubai em Teresina**, 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/pi/piaui/especial-publicitario/sa-cavalcante-la-reserve/noticia/2023/11/22/la-reserve-da-a-largada-para-imoveis-de-luxo-com-padrao-dubai-em-teresina.ghtml>. Acesso em: 12 fev. 2025.





Figura 56 Vista aérea do La Reserve com parte da estrutura do Sanatório.⁶⁸

3.4 Movimentos de Preservação

A preservação do patrimônio cultural constitui um campo teórico em constante transformação, cuja compreensão ultrapassa a simples proteção material das edificações, incorporando dimensões simbólicas, sociais e urbanas. Ao longo do século XX, a noção de patrimônio ampliou-se progressivamente, passando de uma concepção centrada no monumento isolado para um entendimento que reconhece os bens culturais como parte integrante das dinâmicas urbanas e das construções coletivas de memória.

Nesse processo, destaca-se a contribuição de Alois Riegl, que, ainda no início do século XX, estabeleceu a distinção entre os diferentes valores atribuídos aos monumentos, ressaltando sua função social de transmissão da memória. Para o autor, o patrimônio não se define apenas por sua materialidade, mas por sua capacidade de manter viva a lembrança de experiências coletivas ao longo do tempo, evidenciando seu caráter socialmente construído.

Essa dimensão simbólica foi posteriormente aprofundada pelas teorias da conservação e do restauro, especialmente na obra de Cesare Brandi, que consolidou a

⁶⁸ *Idem.*



ideia de que a preservação deve conciliar simultaneamente valores históricos e estéticos. Segundo o autor:

A intervenção de restauro deverá ser sempre e facilmente reconhecível; mas sem que por isso se venha a infringir a própria unidade que se visa a reconstruir. Desse modo, a integração deverá ser invisível à distância de que a obra de arte deve ser observada, mas reconhecível de imediato quando se chega a uma visão mais aproximada.⁶⁹

A teoria introduz, portanto, um princípio fundamental: preservar não significa congelar o bem no tempo, mas garantir sua continuidade histórica sem apagar as marcas de sua trajetória. A preservação passa a ser entendida como prática crítica, que envolve escolhas, interpretações e responsabilidades sociais.

Nas últimas décadas, esse entendimento foi ampliado com a incorporação de perspectivas urbanas e participativas, que situam o patrimônio no contexto mais amplo da produção da cidade. Nesse sentido, Somekh e Fregonezi (2017) destacam que a preservação não pode ser tratada como ação isolada, mas como componente estrutural das políticas urbanas, articulando memória, identidade e planejamento territorial.

Nesse contexto teórico, a preservação do patrimônio deixa de ser compreendida como um ato meramente técnico ou jurídico, passando a ser entendida como um processo social e político, marcado por disputas de valores, narrativas e interesses urbanos. A permanência ou a perda de determinados bens não decorre apenas de suas qualidades materiais ou históricas, mas sobretudo da capacidade de mobilização coletiva em torno de seus significados simbólicos.

Assim, conforme indicam as abordagens contemporâneas da preservação, a patrimonialização não ocorre de forma linear ou automática, mas resulta de tensões entre projetos de cidade, dinâmicas econômicas e demandas sociais pela memória. É nesse contexto que se insere a trajetória do antigo Sanatório Meduna, cuja permanência física e reconhecimento patrimonial evidenciam, de maneira exemplar, os limites e contradições dos processos de preservação em cidades marcadas por transformações urbanas aceleradas e fragilidade institucional das políticas culturais.

⁶⁹ BRANDI, Cesare. **Teoria da restauração**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004. p. 47.



A preservação do antigo Sanatório Meduna não foi um processo espontâneo ou isolado, mas resultado direto da mobilização de diversos atores sociais que se posicionaram contra a destruição de um patrimônio de valor arquitetônico, histórico e simbólico para Teresina. Desde o fechamento do hospital, em 2010, a edificação passou a sofrer com o abandono, a deterioração e, posteriormente, com o avanço de interesses privados sobre o terreno onde funcionava o complexo hospitalar. Sua permanência física, mesmo diante da negligência, revela a importância da mobilização comunitária e acadêmica em torno da defesa da memória urbana.

Casos como o do Meduna não são exceções em Teresina. Um paralelo simbólico é o antigo Cine Rex, inaugurado na década de 1939, e por muito tempo um dos principais espaços culturais da cidade. Ainda que sua estrutura física tenha resistido ao tempo, o prédio passou por um longo período de abandono e desuso, o que gerou debates públicos e ações de ativistas e pesquisadores voltadas à sua reativação e preservação. O cinema tornou-se símbolo da vulnerabilidade do patrimônio cultural que, mesmo reconhecido socialmente, permanece à margem das políticas públicas efetivas.

O Cine Rex (Figura 57) representava um marco na modernização cultural de Teresina. Sua arquitetura trazia influências do estilo art déco, visível nas linhas geométricas e na ornamentação da fachada, conferindo ao edifício uma identidade única e expressiva para a época. O interior do cinema era projetado para oferecer conforto e uma experiência de lazer diferenciada, com um amplo auditório e detalhes que valorizavam a circulação e o bem-estar do público.

Mais do que um espaço de exibição cinematográfica, o Cine Rex funcionava como ponto de encontro social e cultural. Contudo, com a chegada das novas tecnologias e mudanças nos padrões de consumo cultural, o cinema acabou perdendo sua função original, entrando em um longo período de abandono que agravou a deterioração do imóvel.

As discussões sobre a reabilitação do Cine Rex evidenciam a importância de resgatar esses espaços como patrimônios vivos, capazes de contribuir para a memória coletiva e para a revitalização do centro histórico de Teresina. Tal esforço esbarra na ausência de políticas públicas estruturadas, o que coloca em risco não apenas a integridade física do edifício, mas também o seu potencial simbólico e social.





Figura 57 Cine Rex de Teresina.⁷⁰

Outro exemplo emblemático é o da Avenida Frei Serafim (58 e 59), eixo estruturante do crescimento urbano de Teresina ao longo do século XX. Como mostra Moreira (2016), a avenida foi inicialmente caracterizada por residências sofisticadas de tipologia eclética e modernista, projetadas e construídas por engenheiros e mestres de obras notáveis.



Figura 58 Vista aérea da Avenida Frei Serafim (ao centro), onde vê-se a predominância de sobrados. Data imprecisa.⁷¹

⁷⁰ Fonte: Coordenação de Registro e Conservação – CRC/SECULT.

⁷¹ Fonte: Acervo FUNDAC.





Figura 59 Vista aérea da Avenida Frei Serafim ocupada por edifícios, em 2023.⁷²

Essas edificações eram não apenas marcos arquitetônicos, mas também símbolos da transformação da cidade e da vida burguesa teresinense. Com o tempo, no entanto, a avenida foi sendo ocupada por edifícios institucionais e comerciais, resultando em sucessivas demolições e descaracterizações. As residências com fachadas ornamentadas, jardins frontais e soluções climáticas regionais deram lugar a construções genéricas e ao adensamento funcional da área.

A pesquisadora Larissa Tollstadius (2013) observa que os processos de patrimonialização em Teresina são marcados por rupturas e contradições. Para ela, a patrimonialização não se dá de forma linear, do reconhecimento técnico ao tombamento oficial, mas como um processo cíclico e socialmente disputado. Os valores patrimoniais emergem de narrativas múltiplas e em constante reformulação, nas quais se entrelaçam desejos coletivos, disputas políticas e interesses econômicos.

Tollstadius (2013) também evidencia a necessidade de integração entre as políticas de preservação e o planejamento urbano, ressaltando que o território só pode ser preservado de forma efetiva se houver uma gestão articulada entre poder público, técnicos, sociedade civil e comunidade usuária dos espaços. A ausência de ações coordenadas tem levado à destruição sistemática de referências históricas, não apenas físicas, mas também simbólicas.

⁷² Fonte: Portal Verona, 2023.



Além disso, como defende Zanirato (2018), o patrimônio não é determinado apenas por sua historicidade ou materialidade, mas sobretudo pelas emoções e relações afetivas que provoca. Isso reforça a importância de reconhecer os vínculos da população com espaços como o Sanatório Meduna, o Cine Rex, edificações da Avenida Frei Serafim, cuja preservação também representa a defesa do direito à memória, à identidade e ao pertencimento urbano.

Nesse contexto, também se destacam iniciativas temporárias de ativação cultural que buscaram ressignificar o antigo Sanatório Meduna. Entre elas, destaca-se a atuação do Coletivo Salve Rainha, grupo artístico e cultural formado por jovens de Teresina que, entre 2014 e 2018, promoveu ocupações urbanas em espaços públicos e edificações subutilizadas da cidade.

Segundo Moura (2022), os coletivos urbanos desse período tensionavam o uso dos espaços públicos por meio de intervenções culturais e artísticas, mobilizando debates sociais e propondo novas formas de apropriação do território. No caso do Salve Rainha, suas ações buscavam “ocupar e reivindicar espaços esquecidos da cidade, mobilizando arte, cultura e memória como forma de reflexão urbana” (Figura 60).



Figura 60 Rodas de Conversa na Temporada de Carnaval, no prédio do antigo Sanatório Meduna, 2017.⁷³

⁷³ MOURA, Alexandre Pajeú. **A cidade entre acervos: fragmentos do coletivo Salve Rainha e Torquato Neto em Teresina-PI.** 2022. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022.



Em 2017, o grupo realizou atividades no antigo Sanatório Meduna, promovendo eventos culturais, rodas de conversa e intervenções artísticas que tinham como objetivo ressignificar as memórias associadas ao lugar e discutir temas como saúde mental e direito à cidade. Essas ações demonstram como práticas culturais podem atuar como instrumentos de ativação simbólica do patrimônio, ainda que de forma temporária e sem respaldo institucional.

Assim, os movimentos de preservação em Teresina não são apenas lutas por edifícios antigos, mas formas de contestação às lógicas de apagamento que acompanham o crescimento urbano pautado por interesses econômicos. A trajetória do antigo Sanatório Meduna evidencia de forma clara as fragilidades que marcam os processos de preservação do patrimônio em Teresina.

Sua permanência física ao longo da última década não resultou de uma política pública estruturada de salvaguarda, mas de um conjunto de ações fragmentadas, impulsionadas sobretudo pela mobilização acadêmica, por iniciativas da sociedade civil e pela resistência material do próprio edifício frente às sucessivas tentativas de descaracterização.

A mobilização acadêmica também desempenhou papel significativo na construção de reflexões sobre possíveis caminhos de preservação e requalificação do antigo Sanatório Meduna. Alguns trabalhos de conclusão de curso passaram a investigar não apenas os valores históricos e simbólicos do conjunto, mas também a propor alternativas concretas de intervenção capazes de articular preservação patrimonial, uso social e integração urbana.

Essas iniciativas evidenciam o papel da universidade como agente ativo nos processos de patrimonialização, ao produzir conhecimento técnico, registrar a memória arquitetônica e projetar cenários futuros para bens ameaçados. Entre essas contribuições, destacam-se duas propostas desenvolvidas em 2018, que apresentam diferentes estratégias de ressignificação do complexo, ambas fundamentadas no princípio de adaptação de uso como instrumento de preservação.

Uma das propostas acadêmicas relevantes é o trabalho desenvolvido por Miranda (2018), que propõe a adaptação do antigo Sanatório Meduna para a implantação do Museu do Invisível. A proposta parte do reconhecimento do edifício como marco histórico da psiquiatria piauiense e como elemento constitutivo da memória urbana de Teresina.



O projeto tem como eixo conceitual a valorização das dimensões materiais e imateriais do patrimônio, buscando resgatar não apenas a arquitetura do conjunto, mas também as narrativas associadas ao tratamento psiquiátrico e à história social dos pacientes internados no local. Nesse sentido, a intervenção propõe a criação de espaços museológicos voltados à reflexão crítica sobre a saúde mental e os processos de invisibilização social historicamente associados aos manicômios.



Figura 61 Proposta do Museu do Invisível, elaborado em 2018.⁷⁴



Figura 62 Proposta do Museu do Invisível, elaborado em 2018.⁷⁵

⁷⁴ MIRANDA, Ana Elisa Cavalcante. **Proposta de adaptação do antigo Sanatório Meduna de Teresina – Piauí: Museu do Invisível.** 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto Camillo Filho, Teresina, 2018.

⁷⁵ MIRANDA, Ana Elisa Cavalcante. **Proposta de adaptação do antigo Sanatório Meduna de Teresina – Piauí: Museu do Invisível.** 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto Camillo Filho, Teresina, 2018.



Outra contribuição significativa é o trabalho desenvolvido por Carvalho (2018), que propõe a adaptação do antigo sanatório para a implantação da Biblioteca Dom Quixote, voltada especialmente ao público infantojuvenil.

A proposta fundamenta-se na compreensão do patrimônio como elemento essencial para a construção da identidade coletiva e da memória urbana, defendendo que a preservação do edifício depende de sua reintegração à vida cotidiana da população. Nesse sentido, a biblioteca é concebida como espaço de disseminação do conhecimento, capaz de estimular o sentimento de pertencimento da comunidade em relação ao bem cultural.

O projeto prevê a requalificação arquitetônica do conjunto, incluindo levantamento métrico, diagnóstico de patologias e adequações espaciais compatíveis com o novo uso, buscando assegurar a conservação dos elementos originais e a valorização de sua representatividade histórica.

Nesse sentido, a preservação do Sanatório Meduna evidencia limites estruturais das políticas patrimoniais quando estas não se articulam ao planejamento urbano mais amplo. Como argumentam Somekh e Fregonezi (2017, p. 38):

A preservação do patrimônio cultural não pode ser compreendida como um ato isolado de proteção de objetos, mas como parte integrante da política urbana. Quando dissociada do planejamento da cidade e da participação efetiva da sociedade, a preservação tende a se reduzir a procedimentos burocráticos, incapazes de garantir a continuidade simbólica e social dos bens protegidos.⁷⁶

A trajetória do Meduna confirma essa perspectiva, uma vez que sua permanência física ao longo da última década não resultou de uma política pública estruturada de salvaguarda, mas de um conjunto de ações fragmentadas, impulsionadas sobretudo pela mobilização acadêmica, por iniciativas da sociedade civil e pela resistência material do próprio edifício frente às sucessivas tentativas de descaracterização.

⁷⁶ SOMEKH, Nadia; FREGONEZI, Giovana. Patrimônio cultural e participação: construções para um Estado contemporâneo. Revista CPC, São Paulo, n. 22, p. 220-241, jul./dez. 2016.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arquitetura vinculada ao tratamento em saúde mental integra de forma indissociável os processos de produção do espaço urbano e de construção da memória coletiva. Longe de se restringirem à função assistencial, essas edificações concentram valores históricos, simbólicos e espaciais que permanecem inscritos na cidade mesmo após o encerramento de suas atividades. O antigo Sanatório Meduna, nesse sentido, constitui um elemento fundamental para a compreensão da paisagem cultural de Teresina e das relações entre arquitetura, loucura e cidade.

Os espaços psiquiátricos materializam concepções sociais sobre cuidado, controle e exclusão, ao mesmo tempo em que participam ativamente da organização do território urbano. A arquitetura atua como agente estruturador dessas relações, produzindo significados, condicionando usos e definindo formas de apropriação do espaço. O Meduna integrou-se a esse processo como parte da cidade, acompanhando suas transformações e sendo progressivamente ressignificado no interior da dinâmica urbana.

A supressão física do edifício evidencia que a perda arquitetônica não se limita à demolição de uma construção, mas implica a interrupção de leituras possíveis sobre a história urbana, social e cultural do lugar. A fragilidade da preservação do patrimônio moderno, sobretudo quando associada a funções socialmente estigmatizadas, revela a seletividade das políticas urbanas e patrimoniais e os critérios restritos que ainda orientam o reconhecimento do que deve ou não ser preservado.

Nesse contexto, a memória urbana mostra-se profundamente vinculada a escolhas políticas e econômicas que definem quais narrativas permanecem visíveis na cidade. A substituição do antigo sanatório por novos empreendimentos explicita como determinadas experiências coletivas são progressivamente apagadas do espaço urbano, não por ausência de relevância, mas pela dificuldade de incorporá-las aos discursos dominantes de valorização e progresso.

Ao articular arquitetura, cidade e memória, este trabalho reforça a importância de reconhecer edificações vinculadas à história da saúde mental como documentos urbanos, capazes de revelar tensões, silêncios e permanências que atravessam a formação da cidade. A preservação desses espaços não se coloca apenas como questão técnica ou legal, mas como prática crítica de leitura do território, fundamental para a construção de uma memória urbana mais plural e inclusiva.



REFERÊNCIAS

- ABREU, Irlane Gonçalves de. **O crescimento da zona Leste de Teresina: um caso de segregação?** 1983. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1983.
- ACKERKNECHT, Erwin Heinz. **Breve história da psiquiatria**. 2. ed. Buenos Aires: Universitaria, 1964.
- ARRUDA, Elso. **Resumo histórico da psiquiatria brasileira**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1995.
- ASSIS, Joaquim Maria Machado de. **O alienista**. Porto Alegre: L&PM Pocket, 1998.
- BRANDI, Cesare. **Teoria da restauração**. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004.
- CARDOSO, Luciene Brito. **Paisagem do centro de Teresina/PI: os significados dos elementos morfológicos**. 2006. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.
- CARVALHO, Thais Oliveira. **Biblioteca Dom Quixote: adaptação do Sanatório Meduna como proposta de ressignificação desse patrimônio cultural em Teresina-PI**. 2018. Trabalho Final de Graduação (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) — Faculdade Pitágoras, Instituto Camillo Filho, Teresina, 2018.
- CIDADE VERDE. **Shopping Rio Poty é lançado em THE e promete gerar três mil empregos**. Teresina, 22 mar. 2012. Disponível em: <https://cidadeverde.com/noticias/97671/shopping-rio-poty-e-lancado-em-the-e-promete-gerar-tres-mil-empregos>. Acesso em: 10 maio 2025.
- CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. Tradução de Luciano Vieira Machado. 3. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2001.



COSTA, Rômulo G. R. **Arquitetura e saúde no Rio de Janeiro**. In: PORTO, Antônio (org.). **História da saúde no Rio de Janeiro: instituições e patrimônio arquitetônico (1808–1958)**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008. p. xx–xx.

COSTA, Sângela Cotrim Marques. **O Hospital Psiquiátrico do Juqueri: espaço, trabalho e práticas terapêuticas**. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2018.

FAÇANHA, Antônio Cardoso. **Evolução urbana em Teresina: agentes, processos e formas espaciais da cidade**. 1998. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1998.

FOUCAULT, Michel. **História da loucura na idade clássica**. São Paulo: Perspectiva, 1978.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Petrópolis: Vozes, 2010.

FRANKLIN, Camila Fortes Monte. **Stultifera navis: a invisibilidade do louco nas matérias dos jornais O Dia e O Piauí no mês de inauguração do Sanatório Meduna**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Jornalismo) – Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2017.

FREUD, Sigmund. **Arte, literatura e os artistas**. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.

FREYRE, Gilberto. **Sobrados e mucambos**. São Paulo: Global, 2004.

GOFFMAN, Erving. **Manicômios, prisões e conventos**. São Paulo: Perspectiva, 2015.

JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.



LIMA, Nicanor Carvalho de (org.). **Páginas da história do Piauí colonial e provincial.** Teresina: EDUFPI, 2020.

LOPES, Luciana Carvalho. **Impactos ambientais no rio Parnaíba e seus reflexos no desenvolvimento da cidade de Teresina.** 2016. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016.

MELO, Alcília Afonso de Albuquerque. **Arquitetura de Teresina: 150 anos – da origem à contemporaneidade.** Teresina: Halley, 2002.

MELO, Constance de Carvalho Jacob. **Expansão urbana do município de Teresina e as políticas habitacionais a partir de 1966.** 2009. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.

MIRANDA, Ana Elisa Cavalcante. **Proposta de adaptação do antigo Sanatório Meduna de Teresina – PI: Museu do Invisível.** 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto Camillo Filho, Teresina, 2018.

MONTANER, Josep Maria. **Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade do século XX.** Barcelona: Gustavo Gili, 2011.

MONTEIRO, Flávia de Azevedo. **O patrimônio arquitetônico da saúde: discussões sobre a arquitetura hospitalar brasileira do século XIX.** 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2014.

MOREIRA, Amanda Cavalcante. **Teresina e as moradias da região central da cidade (1852–1952).** 2016. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.

MOREIRA, A. A. N. et alii. A cidade de Teresina. Boletim Geográfico. Rio de Janeiro, IBGE, n.230, 1972.



MOURA, Alexandre Pajeú. *A cidade entre acervos: fragmentos do coletivo Salve Rainha e Torquato Neto em Teresina-PI*. 2022. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022.

MOURA, Wilmar de Souza Junior; D'ELBOUX, Roseli Maria Martins. **Igrejas da “Cajuína Teresina”: marcos da paisagem da capital piauiense**. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 17., 2021, São Paulo. Anais... São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2021.

NETO, Torquato. **Torquatália: do lado de dentro**. Rio de Janeiro: Rocco, 2004.

OLIVEIRA, Edmar. **A incrível história de von Meduna e a filha do sol do equador**. Teresina: Oficina da Palavra, 2011

PELBART, Peter Pál. **Da clausura do fora ao fora da clausura: loucura e desrazão**. São Paulo: Brasiliense, 1989.

PESSOTTI, Isaías. **A loucura e as épocas**. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.

PIAUÍ (Estado). Decreto nº 20.201, de 5 de novembro de 2021. Declara como Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Estado do Piauí o edifício do antigo Sanatório Meduna. Diário Oficial do Estado do Piauí, Teresina, 5 nov. 2021. Disponível em: <https://www.pi.gov.br/noticias/estado-decreta-o-tombamento-do-edificio-do-sanatorio-meduna>.

PINHEIRO, Caroline Campos. **Presente e passado do Complexo Hospitalar do Juquery: uma análise do uso do espaço ao longo do tempo**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Turismo) – Universidade de São Paulo, 2022.

PIZZOLATO, Pier Paolo Bertuzzi. **O Juquery: sua implantação, projeto arquitetônico e diretrizes para uma nova intervenção**. 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.



PRADO JUNIOR, Caio. **Formação do Brasil contemporâneo**. São Paulo: Brasiliense, 2000.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da arquitetura no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1987.

RISÉRIO, Antônio. **A cidade no Brasil**. São Paulo: Editora 34, 2012.

ROSA, Iná. **Arquitetura e loucura: o Hospital Psiquiátrico do Juqueri e o modelo manicomial no Brasil**. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

SILVA, Luciene Ribeiro da. **Paisagem cultural do centro de Teresina – PI: estrutura urbana, memória e identidade**. 2017. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017.

SILVA, Maria Aparecida. **O Hospital Psiquiátrico do Juqueri e a formação do município de Franco da Rocha**. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.

SOMEKH, Nadia; FREGONEZI, Bruna. **Patrimônio cultural e participação: construções para um Estado contemporâneo**. Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 26–39, jan./jul. 2017.

TOLLSTADIUS, Larissa Lira. **Preservação do centro de Teresina: a construção de um objeto**. 2013. Dissertação (Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 2013.

VIECELI, Ana Paula. **Lugares da loucura: arquitetura e cidade no encontro com a diferença**. 2014. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.



ZANIRATO, Silvia Helena. **Patrimônio afetivo e paisagens culturais: novas abordagens para a preservação do patrimônio urbano**. In: OLIVEIRA, Antonella Carvalho de (org.). A paisagem urbana e seus múltiplos sentidos. São Paulo: Atena Editora, 2021. p. 36–52.

